



Nuansa
Fajar
Cemerlang

EDUKASI MANAJEMEN NYERI DENGAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SIKAP, DAN PRAKTIK IBU DALAM MANAJEMEN NYERI ANAK SELAMA HOSPITALISASI

Dera Alfiyanti
Vivi Yosafianti Pohan

**EDUKASI MANAJEMEN NYERI
DENGAN MEDIA ELEKTRONIK
UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN,
SIKAP, DAN PRAKTIK IBU DALAM
MANAJEMEN NYERI ANAK
SELAMA HOSPITALISASI**

Ns. Dera Alfiyanti, M.Kep.

Dr. Ns. Vivi Yosafianti Pohan, M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Edukasi Manajemen Nyeri Dengan Media Elektronik Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Ibu Dalam Manajemen Nyeri Anak Selama Hospitalisasi

Penulis: Ns. Dera Alfiyanti, M.Kep.
Dr. Ns. Vivi Yosafianti Pohan, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7139-92-4

Cetakan Pertama: Maret, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

PRAKATA

Buku monograf yang berjudul “Edukasi Manajemen Nyeri dengan Media Elektronik untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Ibu dalam Manajemen Nyeri Anak Selama Hospitalisasi”, disusun sebagai panduan dalam memahami serta mempraktikkan manajemen nyeri pada anak selama dirawat di rumah sakit. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi orang tua (khususnya ibu) dan tenaga kesehatan (lhususnya perawat) untuk meningkatkan wawasan tentang manajemen nyeri pada anak selama hospitalisasi. Perawat dapat mengambil referensi dari buku ini sebagai dasar intervensi edukasi kepada orang tua.

Nyeri pada anak, terutama yang terjadi selama anak dirawat di rumah sakit (hospitalisasi), sering kali tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan optimal. Apabila penanganan nyeri tidak optimal, maka berisiko mempengaruhi proses penyembuhan, lama hari rawat, dan kualitas hidup anak. Melalui buku ini, diharapkan keluarga dapat berperan aktif dalam manajemen nyeri pada anak, sementara petugas kesehatan dapat lebih memahami pentingnya keterlibatan keluarga dalam tatalaksana nyeri. Media elektronik dirancang agar mudah diakses dan dipahami, memberikan informasi yang bermanfaat untuk menciptakan lingkungan perawatan anak yang minim trauma (*atraumatic care*), lebih empatik dan efektif.

Tujuan utama dari buku ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan baik pada keluarga maupun tenaga kesehatan dalam mengelola nyeri pada anak. Penulis berharap buku ini dapat memotivasi dan memberi inspirasi agar lebih banyak keluarga yang terlibat aktif dalam perawatan anak di rumah sakit, serta mendorong petugas kesehatan untuk lebih mengedepankan pendekatan yang inklusif dalam pengelolaan nyeri. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya manajemen nyeri

yang terintegrasi, diharapkan tatalaksana nyeri pada anak dapat mencapai hasil yang adekuat. Buku ini bukan hanya sebuah referensi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kolaborasi antara keluarga dan tenaga medis dalam menciptakan pengalaman perawatan yang lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, baik dari segi pemikiran, penelitian, saran/ide, maupun editing dan proses penerbitan yang telah memberikan kontribusinya. Semoga buku ini bisa memberikan wawasan baru bagi para pembaca, terutama keluarga yang menjadi bagian penting dalam proses perawatan dan penyembuhan anak, serta petugas kesehatan yang memiliki peran krusial dalam memberikan perawatan yang holistik.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 PENDAHULUAN1

BAB 2 NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI.....	5
A. Pengertian Hospitalisasi.....	5
B. Dampak Hospitalisasi.....	6
C. Definisi Nyeri.....	7
D. Penyebab Nyeri Selama Hospitalisasi.....	7
E. Proses Terjadinya Nyeri.....	9
F. Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri Pada Anak.....	10
G. Dampak Nyeri Bagi Anak.....	12

BAB 3 MANAJEMEN NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI.....	17
A. Definisi dan Urgensi Manajemen Nyeri Anak.....	17
B. Penilaian dan Evaluasi Nyeri Pada Anak.....	20
C. Strategi Farmakologis Dalam Manajemen Nyeri.....	22
D. Strategi Non Farmakologis Dalam Manajemen Nyeri.....	24

BAB 4 EDUKASI KELUARGA TENTANG MANAJEMEN NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI.....	31
A. Definisi Edukasi Orang Tua.....	31

B. Tujuan Edukasi Manajemen Nyeri Anak.....	32
C. Metode Edukasi Manajemen Nyeri Anak	34
D. Proses Edukasi Manajemen Nyeri Anak	38

BAB 5 MEDIA ELEKTRONIK “KIDS PAIN CARE MANAJEMEN NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI: PANDUAN BAGI ORANG TUA” 41

A. Definisi Media Elektronik	41
B. Manfaat Media Elektronik	43
C. Isi Media Elektronik “ <i>Kids Pain Care</i> Manajemen Nyeri Pada Anak Selama Hospitalisasi: Panduan Bagi Orang Tua”	44

BAB 6 PARTISIPASI ORANG TUA DALAM MANAJEMEN NYERI ANAK SELAMA HOSPITALISASI 59

A. Pengetahuan Orang Tua Tentang Manajemen Nyeri Anak	59
B. Sikap Orang Tua Dalam Manajemen Nyeri Anak	61
C. Praktik Orang Tua Dalam Manajemen Nyeri Anak	62
D. Partisipasi Orang Tua dalam Manajemen Nyeri Anak	63

BAB 7 PENUTUP 69

DAFTAR PUSTAKA..... 71

GLOSARIUM 87

PROFIL PENULIS 91

BAB 1

PENDAHULUAN

Hospitalisasi merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan seorang anak harus dirawat inap di rumah sakit, akibat cedera atau injuri, pemeriksaan diagnostik, penyakit akut, maupun penyakit kronis (Claridge & J Powell, 2022). Anak berisiko mengalami stres, baik stres fisik maupun stres psikologis akibat dari prosedur yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi anak (nyeri, rasa takut, lingkungan yang asing, kehilangan kendali diri) (Delvecchio, Salcuni, Lis, Germani, & Riso, 2019; Mediani et al., 2019; Perdani et al., 2021). Nyeri adalah pengalaman yang kompleks bagi anak dan merupakan keluhan yang paling sering bagi anak yang menjalani perawatan di rumah sakit (hospitalisasi). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa nyeri akut merupakan keluhan yang paling banyak terjadi pada pasien anak yang dirawat di rumah sakit, dengan intensitas nyeri sedang hingga berat (De Souza et al., 2024). Nyeri yang tidak terkontrol/teratasi dengan baik memberikan dampak negatif bagi anak yang menjalani hospitalisasi. Meskipun telah ada pedoman dan standar praktik terkait manajemen nyeri, banyak anak yang dirawat di rumah sakit terus mengalami nyeri yang tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa obat pereda nyeri saja tidak cukup untuk meredakan ketidaknyamanan mereka.

Manajemen nyeri pada anak membutuhkan terapi nonfarmakologis (terapi tidak menggunakan obat) yang melibatkan orang tua, terutama ibu (Jordan et al., 2021; Lassetter, 2006). Sebuah survei penelitian di Amerika Serikat

yang melibatkan 32 rumah sakit menemukan bahwa 86% anak yang dirawat di rumah sakit mengalami nyeri, 40% di antaranya melaporkan nyeri sedang hingga berat (S. Friedrichsdorf et al., 2015). Penelitian di Indonesia menyimpulkan bahwa 82% anak yang dirawat mengalami nyeri, 42% mengalami nyeri sedang hingga berat (Duran et al., 2020; Wati, 2016). Data dari rumah sakit anak di seluruh dunia menjelaskan bahwa nyeri pada pasien anak mulai dari usia bayi hingga remaja merupakan hal yang umum terjadi, kurang dikenali, dan kurang ditangani dengan optimal (S. J. Friedrichsdorf & Goubert, 2020). Nyeri yang tidak teratasi dengan baik telah terbukti memiliki konsekuensi yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tatalaksana nyeri dengan kombinasi strategi fisik, psikologis, farmakologi, dan nonfarmakologi dapat bekerja lebih efektif untuk mengurangi nyeri pada anak selama dirawat di rumah sakit dari pada strategi tunggal saja (Chumpitazi et al., 2022).

Nyeri pada anak harus dinilai secara teratur dan dilakukan tindakan secara berkelanjutan. Penting bagi orang tua/keluarga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan bersama mengenai penilaian dan penanganan nyeri. Panduan harus diberikan kepada orang tua tentang penggunaan skala penilaian nyeri dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri anak (Palomaa et al., 2023). Partisipasi orang tua dalam perawatan adalah proses dinamis yang komprehensif, multidimensi, dan terus berkembang, yang melibatkan partisipasi orang tua dalam pengambilan keputusan dan implementasi atau evaluasi tindakan. Orang tua berperan sebagai konsultan untuk masalah yang dialami oleh anak (Jackie et al., 2019; Manuela et al., 2019; Wen-ying et al., 2018; Yang et al., 2023).

Orang tua seringkali mengungkapkan keinginan dan kebutuhan untuk terlibat dalam perawatan anak mereka yang dirawat di rumah sakit dengan melakukan tugas perawatan yang biasa mereka lakukan, akan tetapi seringkali tidak dapat melaksanakan hal tersebut karena bingung akan peran mereka di rumah sakit (Xiao et al., 2020; Yang et al., 2023). Orang tua terutama ibu memerlukan informasi yang detail tentang partisipasi yang dapat mereka berikan dalam perawatan anak di rumah sakit. Ibu harus dapat mengenali nyeri yang dirasakan oleh anak, menilai berat ringannya nyeri, serta dapat melakukan tindakan mandiri untuk mengurangi atau mengontrol nyeri yang dialami oleh anak. Perawat sebagai edukator dan manajer perawatan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada ibu.

Edukasi dan panduan yang proper sangat dibutuhkan. Edukasi yang efektif bergantung pada beberapa aspek, antara lain metode, lingkungan, dan media pembelajaran. Media pembelajaran audio visual, booklet, atau aplikasi berbasis *smartphone*, dapat menyampaikan informasi dengan lebih mudah dipahami dan diakses oleh ibu, memperjelas keterampilan yang akan diajarkan, dan mempermudah akses untuk repetisi/pengulangan materi. Salah satu media yang dikembangkan dalam pendidikan kesehatan adalah media elektronik tentang manajemen nyeri pada anak selama hospitalisasi. Media ini dikembangkan secara digital berdasarkan referensi mutakhir dan hasil-hasil penelitian terkini dalam manajemen nyeri anak.

Media elektronik manajemen nyeri pada anak selama hospitalisasi berisi panduan praktis bagi orang tua untuk menilai dan mengurangi nyeri yang dialami oleh anak. Materi yang terdapat di dalam media edukasi meliputi pendahuluan, definisi nyeri, penyebab nyeri, cara mengenali nyeri, cara

mengukur nyeri, terapi obat, tindakan tanda obat, simpulan, penutup, dan referensi. Media elektronik dapat menampilkan informasi secara interaktif dengan visualisasi yang menarik, yaitu gambar disertai penjelasan ringkas yang dapat meningkatkan pemahaman tentang manajemen nyeri pada anak. Selain itu, format digital memungkinkan ibu untuk mengulang materi yang belum dipahami. Booklet elektronik juga sesuai dengan karakteristik media informasi terkini (*electronic based*). Hal ini menjadikan booklet elektronik sebagai alat edukasi yang efisien dan efektif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik yang diberi judul "*E-Booklet Kids Pain Care* Manajemen Nyeri Pada Anak Selama Hospitalisasi: Panduan Bagi Orang Tua" terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik ibu dalam manajemen nyeri anak selama dirawat di rumah sakit. Booklet tersebut dapat digunakan langsung oleh ibu, digunakan oleh perawat sebagai media dalam menyampaikan pendidikan kesehatan untuk keluarga di unit-unit perawatan anak, maupun sebagai media fasilitator dalam *discharge planning* anak.

BAB 2

NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI

A. Pengertian Hospitalisasi

Hospitalisasi merupakan sebuah kondisi yang disebabkan oleh alasan tertentu, baik secara terencana atau darurat, sehingga anak harus dirawat di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai dengan pemulangan kembali ke rumah (Ferreira et al., 2019). Hospitalisasi juga merupakan kondisi akut atau kronis, trauma, terapi, dan pemeriksaan diagnostik yang memerlukan intervensi, sehingga anak harus menjalani perawatan di rumah sakit (Lulgjuraj & Maneval, 2021). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hospitalisasi merupakan suatu kondisi yang mengharuskan anak menjalani perawatan di rumah sakit sampai dengan pemulangan kembali ke rumah.

Hospitalisasi adalah pengalaman yang menyebabkan stres pada anak, yang disebabkan karena nyeri, lingkungan yang tidak dikenal, berpisah dengan keluarga, dan interaksi dengan tenaga kesehatan di rumah sakit (Sillero et al., 2024). Pengalaman yang stresful juga dipengaruhi oleh gejala penyakit, dan/atau prosedur invasif (prosedur yang menimbulkan rasa sakit), yang dilakukan sebagai tindakan rutin. Nyeri yang dialami anak selama hospitalisasi sangat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan proses penyakit namun juga disebabkan karena berbagai tindakan

pemeriksaan diagnostik dan tindakan pengobatan (Carvalho et al., 2022).

B. Dampak Hospitalisasi

Pengalaman dirawat di rumah sakit merupakan pengalaman yang menimbulkan kecemasan dan bahkan trauma, terutama bagi anak. Anak sangat rentan terhadap dampak negatif akibat suatu penyakit dan perawatan di rumah sakit (hospitalisasi). Rawat inap di rumah sakit merupakan peristiwa yang penuh dengan kejadian traumatik bagi anak. Anak harus belajar beradaptasi, bukan hanya adaptasi terhadap penyakit atau perubahan kondisi fisik, namun juga adaptasi terhadap lingkungan serta rutinitas baru yang seringkali menyebabkan ketidaknyamanan. Anak memiliki keterbatasan kognitif dan psikologis (emosional) serta ketergantungan pada orang lain, sehingga menyebabkan mereka sangat rentan terhadap stres (Rokach, 2016a).

Penyakit dan hospitalisasi merupakan hal yang traumatis, menimbulkan kecemasan, dan dapat menyebabkan gangguan perilaku dan psikologis sementara atau jangka panjang pada anak-anak. Masalah emosional yang diakibatkan oleh pengalaman di rumah sakit telah dilaporkan bervariasi dari 10% hingga 30% untuk tekanan psikologis yang parah dan sebanyak 90% untuk gangguan emosional ringan (Delvecchio, Salcuni, Lis, Germani, & Di Riso, 2019; Rokach, 2016b). Selain dampak psikologis, hospitalisasi juga berdampak pada aspek fisik dan sosial anak.

Dampak fisik hospitalisasi antara lain nyeri berulang, perubahan/gangguan pola dan kualitas tidur anak, risiko mengalami malnutrisi, keterbatasan aktivitas (imobilisasi),

dan beragam ketidaknyamanan fisik lainnya (Burger et al., 2022; Hockenberry & Wilson, 2015; Hybschmann et al., 2021). Nyeri berulang dan berkepanjangan disebabkan karena proses penyakit atau cedera yang dialami oleh anak, pemeriksaan diagnostik tertentu, dan tindakan atau prosedur invasif untuk tujuan kuratif atau pengobatan.

C. Definisi Nyeri

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, disebabkan oleh kerusakan jaringan yang aktual atau risiko. Nyeri merupakan pengalaman somatik yang dapat dikenali berdasarkan laporan/keluhan individu dan hasil observasi, yang mencerminkan kekhawatiran seseorang akan ancaman terhadap integritas tubuh (Raja S et al., 2021). Nyeri bersifat subyektif, dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi faktor fisiologis (biologis), psikologis, dan sosial.

D. Penyebab Nyeri Selama Hospitalisasi

Nyeri yang dialami anak selama hospitalisasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor yang berkaitan dengan penyakit (kondisi medis) maupun yang berkaitan dengan prosedur atau tindakan yang dilakukan. Prosedur medis yang dapat menyebabkan nyeri antara lain pungsi vena untuk pengambilan sampel darah, pemasangan infus, prosedur lumbal pungsi, atau prosedur invasif lainnya. Prosedur tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan meningkatkan kecemasan anak. Anak usia di bawah lima tahun seringkali tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka karena keterbatasan kognitif dan bahasa verbal, sehingga berisiko merasakan nyeri dengan intensitas yang

lebih tinggi akibat ketakutan dan kecemasannya (De Alencar et al., 2024)

Kondisi fisik akibat penyakit juga merupakan sumber utama nyeri pada anak yang dirawat di rumah sakit. Penyakit akut seperti infeksi (misalnya otitis media atau pneumonia) dan cedera atau injuri (misalnya patah tulang atau luka bakar) sering menyebabkan nyeri yang cukup berat pada anak. Penyakit kronis, misalnya kanker juga dapat menyebabkan nyeri berat, berulang atau terus-menerus yang membutuhkan pengelolaan secara intensif. Nyeri seperti ini seringkali disertai dengan kecemasan dan ketidakpastian terkait prognosis, yang memperburuk persepsi nyeri anak (Chumpitazi et al., 2022)

Faktor psikologis juga memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan pengalaman nyeri anak selama hospitalisasi. Kecemasan, stres, dan ketakutan terhadap lingkungan rumah sakit, atau ketidaknyamanan akibat perubahan rutinitas dapat meningkatkan rasa sakit yang dialami anak. Stres emosional akibat dari pemisahan dengan keluarga (orang tua, saudara kandung), keterbatasan interaksi sosial, dan ketidakmampuan anak untuk mengontrol situasi yang dialami memperburuk persepsi nyeri, mengakibatkan ketegangan otot, dan berdampak pada peningkatan rasa sakit yang dirasakan oleh anak (Downey & Crummy, 2022). Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk merencanakan pengelolaan nyeri yang komprehensif pada anak, meliputi intervensi fisik dan psikologis, yang sekaligus dilakukan untuk mengurangi stres dan kecemasan.

E. Proses Terjadinya Nyeri

Nyeri diawali dengan adanya stimulus dari faktor fisik, kimia, atau termal yang menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, yang dikenal sebagai nosiseptor. Stimulus ini diterima oleh ujung saraf sensoris yang ada di kulit, otot, sendi, dan organ tubuh lainnya, kemudian diteruskan dalam bentuk impuls elektrik melalui serabut saraf A-delta dan C ke sumsum tulang belakang. Pada tahap ini, impuls nyeri pertama kali diproses di ganglion akar dorsal dan diteruskan melalui jalur spinothalamus menuju ke otak. Stimulus ini disebut sebagai nyeri somatik (nyeri yang dirasakan pada kulit atau jaringan tubuh) atau nyeri viseral (nyeri yang dirasakan pada organ di dalam tubuh) tergantung pada lokasi dan jenis stimulus yang diterima (Cetinkaya, 2023).

Proses selanjutnya yaitu modulasi nyeri di sumsum tulang belakang. Hal ini menentukan apakah impuls nyeri berkurang atau bertambah. Sistem saraf pusat mempunyai kemampuan untuk mengatur respon terhadap stimulus nyeri. Substantia gelatinosa di sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengatur transmisi impuls nyeri. Transmisi impuls nyeri menjadi kuat melalui jalur yang dikenal sebagai "*upward modulation*" dan diredam melalui jalur "*downward modulation*". Peningkatan dan berkurangnya nyeri dipengaruhi oleh beberapa neurotransmiter, misalnya serotonin dan norepinefrin. Proses ini memengaruhi bagaimana otak menerjemahkan dan merespon nyeri. Apabila terjadi gangguan pada modulasi ini, maka nyeri dapat menjadi kronis atau lebih tinggi intensitasnya (Karcz et al., 2024).

Proses persepsi nyeri terjadi setelah sinyal nyeri mencapai otak. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor emosional, psikologis, dan kognitif individu, yang dapat

meningkatkan atau menurunkan intensitas nyeri. Pengalaman nyeri dipengaruhi oleh multi aspek, yaitu aspek fisik, pengalaman sebelumnya, kecemasan, dan faktor sosial. Otak memproses sinyal nyeri sehingga individu menunjukkan respon, baik berupa perilaku (contohnya menangis atau menarik anggota badan yang sakit) maupun respon fisiologis (misalnya peningkatan detak jantung dan tekanan darah). Respon nyeri pada individu bervariasi meskipun stimulus yang diterima sama (Lambert et al., 2019).

F. Faktor Yang Mempengaruhi Nyeri Pada Anak

Pengalaman nyeri pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, sosial, maupun lingkungan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi persepsi nyeri pada anak adalah usia dan tahap perkembangan kognitif. Anak yang lebih kecil, terutama bayi dan balita, mungkin tidak dapat mengungkapkan nyeri mereka secara verbal. Sebaliknya, anak yang lebih besar atau remaja dapat lebih mudah mengidentifikasi dan menggambarkan rasa sakit mereka, tetapi mungkin mengalami kecemasan atau ketakutan yang memengaruhi cara mereka merasakan nyeri. Misalnya, anak yang lebih muda mungkin menunjukkan respons fisik seperti menangis atau menarik diri, sedangkan anak yang lebih tua mungkin mengeluhkan rasa sakit dengan cara yang lebih verbal atau dengan ekspresi wajah yang lebih jelas (De Souza et al., 2024)

Faktor genetik dan biologis juga memainkan peran penting dalam persepsi nyeri anak. Beberapa anak mungkin memiliki kecenderungan genetik untuk mengalami nyeri yang lebih intens atau nyeri yang lebih lama, terutama dalam kondisi medis tertentu, seperti gangguan nyeri kronis atau

penyakit inflamasi. Selain itu, perbedaan dalam sistem saraf anak, seperti sensitivitas nociceptor (ujung saraf sensorik) atau cara otak memproses sinyal nyeri, dapat memengaruhi bagaimana nyeri dirasakan dan direspons. Penelitian menunjukkan bahwa variasi dalam kadar neurotransmitter tertentu, seperti serotonin dan endorfin, dapat mempengaruhi tingkat keparahan dan durasi nyeri pada anak (Chumpitazi et al., 2022).

Faktor emosional dan psikologis turut memperburuk persepsi nyeri pada anak. Kecemasan, stres, dan ketakutan terhadap prosedur medis atau penyakit yang diderita dapat memperburuk rasa sakit yang dirasakan. Ketika anak merasa cemas, respons fisiologis mereka, seperti peningkatan detak jantung dan ketegangan otot, dapat memperburuk pengalaman nyeri. Anak yang pernah mengalami pengalaman nyeri yang menyakitkan sebelumnya mungkin akan merasa lebih cemas pada prosedur serupa di masa depan, meningkatkan tingkat keparahan nyeri mereka. Oleh karena itu, manajemen nyeri pada anak harus mencakup pendekatan psikologis untuk mengurangi kecemasan dan membantu anak merasa lebih nyaman dan aman di lingkungan rumah sakit (Chumpitazi et al., 2022).

Lingkungan sosial dan dukungan keluarga juga sangat memengaruhi bagaimana anak merasakan dan mengatasi nyeri. Kehadiran orang tua atau pengasuh yang memberikan dukungan emosional dan fisik dapat membantu menurunkan kecemasan anak, yang pada gilirannya dapat mengurangi persepsi nyeri. Anak yang merasa didukung dan aman di lingkungan rumah sakit lebih cenderung untuk merespons pengobatan atau prosedur medis dengan lebih tenang, dibandingkan dengan anak yang merasa terisolasi atau ditinggalkan. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial

yang positif, seperti berbicara dengan orang tua atau bermain dengan teman sebaya, dapat menjadi faktor yang mengurangi persepsi nyeri (Palomares González et al., 2023).

Selain faktor internal dan psikososial, faktor lingkungan fisik di rumah sakit juga memiliki dampak besar terhadap persepsi nyeri pada anak. Lingkungan rumah sakit yang terasa asing atau tidak nyaman dapat meningkatkan kecemasan anak dan memperburuk rasa sakit. Faktor-faktor seperti kebisingan, pencahayaan yang buruk, atau kurangnya privasi dapat meningkatkan stres anak selama perawatan. Sebaliknya, lingkungan yang lebih nyaman, dengan pencahayaan yang lembut, pengaturan ruang yang mendukung, dan pengurangan kebisingan, dapat membantu anak merasa lebih tenang dan mengurangi dampak negatif dari nyeri. Hal ini menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk anak dalam proses penyembuhan (Carvalho et al., 2022).

G. Dampak Nyeri Bagi Anak

Nyeri merupakan stres dalam tubuh dan memiliki efek fisiologis yang tidak diinginkan pada beberapa sistem tubuh. Nyeri akut terutama yang terjadi setelah operasi menyebabkan pernapasan anak cepat dan dangkal serta menghambat batuk. Tindakan yang dilakukan anak untuk menurunkan nyeri dapat menyebabkan komplikasi seperti akumulasi sekret akibat pengembangan paru yang tidak adekuat, penurunan saturasi oksigen, alkalosis, dan atelektasis. Pelepasan katekolamin, glukagon, dan kortikosteroid juga meningkat pada nyeri. Keadaan katabolik yang dihasilkan secara serius mempengaruhi bayi baru lahir dan bayi kecil, terutama mereka yang memiliki tingkat metabolisme yang tinggi dan penyimpanan nutrisi yang

tidak mencukupi. Nyeri pada bayi baru lahir dan bayi juga dapat menguras simpanan energi. Hal ini menyebabkan menipisnya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pemulihan (Cetinkaya, 2023).

Mengendalikan nyeri pasca operasi dapat menunda timbulnya fungsi lambung dan usus dan dapat menyebabkan tukak lambung. Hilangnya nafsu makan yang disebabkan oleh rasa sakit mengurangi penyerapan nutrisi dan menunda proses penyembuhan. Ketidakseimbangan cairan dan elektrolit dapat terlihat pada anak kecil yang berkeringat berlebihan akibat nyeri. Karena sistem saraf otonom tidak stabil selama nyeri, tekanan intrakranial dapat meningkat dan menyebabkan perdarahan intraventrikular. Respons sistem kekebalan tubuh akibat nyeri yang tidak diobati menurun dan kerentanan terhadap infeksi meningkat.

Nyeri berulang pada bayi baru lahir dan bayi dapat menyebabkan ambang nyeri, persepsi nyeri dan toleransi nyeri pada tahap kehidupan selanjutnya, dapat menyebabkan hiperalgesia, menurunkan ambang nyeri dan mengakibatkan peningkatan respons fisiologis dan perilaku dalam situasi yang menyakitkan. Selain itu, defisit perhatian dan defisit belajar dapat meningkatkan risiko gangguan perilaku (Buyukgonenc & Toruner, 2021).

Nyeri yang tidak dilakukan tatalaksana dengan baik pada anak akan mengakibatkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan fisik dan psikologis. Secara fisik, nyeri yang terus meningkat intensitasnya dan berlangsung berkepanjangan dapat mengganggu kualitas tidur anak. Gangguan tidur menyebabkan kelelahan yang dapat menurunkan imunitas tubuh dan memperlambat proses pemulihan. Anak yang kurang tidur cenderung memiliki

respon imun yang lebih rendah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan komplikasi penyakit (Cunico et al., 2023). Oleh karena itu, manajemen nyeri yang efektif sangat penting untuk mendukung pemulihan anak selama hospitalisasi.

Nyeri yang berlangsung lama, sering, atau berulang dapat menghambat atau mengganggu perkembangan motorik anak, baik motorik kasar maupun motorik halus. Nyeri yang dialami dapat menyebabkan keterbatasan kemampuan anak untuk mobilisasi (bergerak bebas), beraktivitas, atau berinteraksi dengan lingkungan. Jika nyeri tidak diatasi dengan baik, hal tersebut dapat memengaruhi tingkat kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik yang penting untuk perkembangan fisiknya, seperti bermain, berjalan, atau berlari.

Dampak psikologis nyeri pada anak yang berkepanjangan yang tidak teratasi juga sangat besar. Dampak tersebut antara lain kecemasan, stres, dan ketakutan. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami nyeri kronis lebih berisiko mengalami gangguan kecemasan dan depresi dibandingkan dengan anak yang mengalami nyeri akut. Ketidakmampuan anak untuk memahami dan mengungkapkan perasaan mereka dengan tepat dapat menyebabkan frustrasi dan ketidakberdayaan (Roessler De Angulo et al., 2024).

Selain dampak fisik dan psikologis, nyeri yang tidak ditangani dengan baik juga dapat memengaruhi kualitas hidup sosial anak. Nyeri berkepanjangan, berulang atau kronis akan menghambat interaksi sosial anak dan partisipasi dalam kegiatan sosial misalnya sekolah, bermain, atau bergaul dengan teman sebaya. Anak cenderung menghindari dari aktivitas karena lebih fokus pada rasa sakit yang mereka

rasakan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hubungan sosial dengan keluarga dan teman sebaya, merasa bosan dan kesepian, serta memengaruhi perkembangan keterampilan sosial anak (Romito et al., 2021). Manajemen nyeri yang tepat tidak hanya penting untuk kesejahteraan fisik anak, akan tetapi juga penting untuk kesejahteraan sosial, psikologis, dan emosional mereka.

BAB 3

MANAJEMEN NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI

A. Definisi dan Urgensi Manajemen Nyeri Anak

Manajemen nyeri pada anak adalah suatu pendekatan terstruktur yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit yang dirasakan oleh anak. Proses evaluasi nyeri pada anak cenderung lebih menantang dibandingkan pada orang dewasa, karena anak biasanya kesulitan dalam mengungkapkan atau menggambarkan rasa sakit yang mereka alami. Oleh karena itu, manajemen nyeri pada anak memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati, dengan mempertimbangkan faktor perkembangan dan aspek psikologis anak. Penanganan nyeri mencakup evaluasi nyeri yang tepat, pemberian intervensi yang sesuai baik secara farmakologis maupun non-farmakologis, serta melibatkan keluarga untuk membantu meningkatkan kenyamanan anak (Cunico et al., 2023; De Alencar et al., 2024).

Manajemen nyeri pada anak dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu manajemen nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut biasanya disebabkan karena cedera atau tindakan medis, sedangkan nyeri kronis seringkali disebabkan oleh penyakit kronis seperti kanker, artritis, dan otitis media kronis. Penilaian nyeri pada anak harus menggunakan skala penilaian yang sesuai dengan usia dan kemampuan komunikasi anak, yaitu skala angka atau wajah (Hockenberry

& Wilson, 2015). Anak yang lebih besar dapat dinilai tingkat nyerinya dengan kuesioner karena pada umumnya pemahaman mereka cukup baik untuk menerima atau memberikan informasi. Pemberian obat analgetik harus disertai dengan pemantauan secara kontinyu dalam manajemen nyeri akut. Intervensi nonfarmakologis, contohnya terapi perilaku dan relaksasi berperan besar dalam manajemen nyeri kronis.

Peran orang tua dan tim pelayanan kesehatan sangat penting dalam keberhasilan penatalaksanaan nyeri pada anak. *Partnership* antara tenaga kesehatan, anak, dan orang tua (terutama ibu) harus ditingkatkan untuk mendukung kontinuitas pengelolaan nyeri yang efektif (van Oort et al., 2019). Penelitian menunjukkan bahwa penggabungan terapi farmakologis dan nonfarmakologis memiliki efektivitas yang lebih baik dalam mengelola nyeri anak dibandingkan dengan satu jenis intervensi saja. Selain itu, monitoring nyeri secara reguler dan modifikasi strategi diperlukan untuk mengatasi perubahan intensitas atau jenis nyeri yang dialami anak (Andersson et al., 2022).

Manajemen nyeri yang efektif pada anak sangat penting untuk mengurangi dampak negatif nyeri yang tidak terkontrol. Nyeri yang tidak teratasi dapat menyebabkan gangguan tidur, penurunan imunitas tubuh, dan hambatan dalam proses pemulihan cedera atau penyakit. Nyeri akut yang terjadi setelah operasi atau prosedur invasif, jika tidak segera diatasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan jangka panjang, yang dapat mengganggu proses penyembuhan penyakit dan memperburuk kondisi fisik anak. Tatalaksana nyeri pada anak yang adekuat dapat mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup anak (Cetinkaya, 2023).

Manajemen nyeri yang tepat juga sangat penting untuk mencegah dampak psikologis. Anak yang mengalami nyeri yang tidak dikelola dengan baik lebih rentan terhadap stres, kecemasan, ketakutan, dan perasaan tidak berdaya (distres) (Sillero et al., 2024). Nyeri kronis atau nyeri yang berkelanjutan mengakibatkan masalah emosional misalnya gangguan mood, gangguan kecemasan dan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman nyeri yang dialami anak selama hospitalisasi dapat menyebabkan gangguan atau perubahan psikologis dalam waktu yang cukup lama, meskipun nyeri fisik telah hilang. Berdasarkan fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen nyeri yang efektif tidak hanya mengurangi ketidaknyamanan fisik, tetapi juga mencegah dampak psikologis jangka panjang (De Alencar et al., 2024).

Manajemen nyeri yang adekuat pada anak berpotensi untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan akibat hospitalisasi. Anak yang bebas dari nyeri cenderung lebih aktif dalam berinteraksi dengan teman sebaya, berpartisipasi aktif dalam aktivitas sosial, dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Sebaliknya, anak yang mengalami nyeri dan tidak teratasi, akan merasa terisolasi dan mengalami keterbatasan dalam interaksi sosial. Hal ini akan menghambat perkembangan personal sosial dan meningkatkan kecemasan. Dengan demikian, manajemen nyeri yang tepat sangat penting mendukung perkembangan sosial anak (Bortolote & Brêtas, 2008)

Urgensi manajemen nyeri pada anak adalah pentingnya pendekatan yang komprehensif (kombinasi beberapa intervensi) dalam upaya mengatasi atau menurunkan tingkat nyeri pada anak. Respon nyeri anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga tatalaksana nyeri

pada anak menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai profesional kesehatan dan partisipasi aktif orang tua untuk merencanakan tindakan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan anak yang spesifik (Maleki et al., 2022).

B. Penilaian dan Evaluasi Nyeri Pada Anak

Penilaian dan evaluasi nyeri diperlukan untuk mengidentifikasi, mengurangi nyeri dan merencanakan intervensi mengontrol nyeri yang efektif. Mengukur dan mengevaluasi nyeri secara akurat pada anak memfasilitasi pengendalian nyeri. Nyeri merupakan pengalaman subjektif dan multidimensi. Orang tua dan tenaga kesehatan sering mengalami kesulitan dalam menilai nyeri pada bayi/anak karena populasi ini memiliki hambatan dalam mengekspresikan nyeri secara verbal. Penilaian nyeri pada anak juga seringkali mengalami hambatan karena adanya kesulitan membedakan respon ketidaknyamanan akibat prosedur yang menyakitkan, kelaparan, kesepian, perpisahan dengan orang tua dan kecemasan (Cetinkaya, 2023).

Nyeri harus dinilai sebelum dan sesudah prosedur yang menyebabkan nyeri (prosedur invasif). Instrumen untuk mengukur tingkat keparahan nyeri pada anak ditentukan berdasarkan pada usia anak, kondisi umum, dan tingkat pengenalan nyeri. Pendekatan tunggal mungkin tidak efektif dalam menilai nyeri, karena nyeri merupakan pengalaman subjektif. Ekspresi anak yang berhubungan dengan nyeri dengan komunikasi verbal adalah cara yang paling dapat diandalkan untuk menilai tingkat keparahan dan lokasi nyeri. Berikut ini akan dideskripsikan penilaian nyeri ditinjau dari beberapa aspek.

1. Pengukuran nyeri berdasarkan tanda gejala fisik

Nyeri akut menstimulasi sistem saraf adrenergik dan mengakibatkan perubahan fisik seperti peningkatan frekuensi denyut jantung, peningkatan frekuensi pernafasan, hipertensi, pelebaran pupil, pucat, berkeringat, penurunan saturasi oksigen, dan peningkatan katekolamin serta pelepasan hormon adrenokortikoid. Meskipun manifestasi fisik dan fisiologis ini menunjukkan respons stres yang kompleks, manifestasi ini mungkin tidak bermanfaat jika digunakan untuk memantau nyeri akut saja, karena tidak spesifik untuk nyeri. Penilaian nyeri secara fisik yang dikombinasikan dengan pengukuran perilaku dan keluhan secara verbal akan meningkatkan keakuratan penilaian nyeri. Tubuh dapat beradaptasi dengan nyeri kronis jangka panjang selama respons stres, sehingga seringkali ditemukan sistem tubuh normal (Buyukgonenc & Toruner, 2021).

2. Pengukuran nyeri berdasarkan perilaku

Skala nyeri perilaku digunakan untuk anak dengan gangguan kognitif dan gangguan komunikasi yang berat. Anak-anak mengekspresikan nyeri dengan cara yang berbeda dengan orang dewasa, seperti menangis, gerakan tubuh yang berbeda, dan emosional. Namun, tidak selalu mudah untuk membedakan perilaku-perilaku ini dari reaksi yang berhubungan dengan sumber stres lainnya, seperti rasa lapar, cemas, dan gelisah. Penggunaan skala nyeri perilaku membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan cara berbasis penyangkalan diri, karena perawat perlu memonitor anak. Selain itu, perilaku anak harus ditafsirkan dengan hati-hati saat menggunakan skala ini. Perilaku santai seperti

menonton televisi, bermain *game*, dan tidur tidak selalu berarti bahwa anak tidak mengalami nyeri, tetapi juga bisa menjadi tanda bahwa ia sedang berusaha untuk beradaptasi dan mengatasi nyeri. Skala pengukuran nyeri perilaku lebih dapat diandalkan untuk nyeri jangka pendek (nyeri akut), akan tetapi keakuratannya menurun ketika nyeri yang diukur bersifat berulang, kronis, dan juga ketika digunakan pada anak yang lebih besar (Cetinkaya, 2023; S. J. Friedrichsdorf & Goubert, 2020).

3. Pengukuran berdasarkan laporan dari individu

Pengukuran berdasarkan laporan diri dianggap sebagai "standar emas" dan merupakan cara yang paling tepat untuk menentukan tingkat nyeri. Laporan keluhan nyeri secara mandiri membutuhkan perkembangan kognitif dan keterampilan verbal, sehingga teknik ini tepat digunakan pada anak usia 3-4 tahun ke atas. Tingkat nyeri, kualitas, lokalisasi dan karakteristik dinilai dengan metode laporan diri. Saat mengumpulkan data, anak harus berpartisipasi dalam proses (Cetinkaya, 2023).

C. Strategi Farmakologis Dalam Manajemen Nyeri

Pendekatan farmakologis dalam penanganan nyeri pada anak melibatkan penggunaan obat-obatan untuk meredakan atau menghilangkan rasa sakit, disesuaikan dengan tingkat dan jenis nyeri yang dialami. Pengobatan nyeri dengan obat ini harus berdasarkan resep dari dokter karena ada berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan. Obat pertama yang sering digunakan adalah analgetik non-opioid, seperti parasetamol dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID), yang efektif untuk nyeri ringan hingga sedang. Parasetamol bekerja dengan menghambat produksi zat-zat kimia yang menyebabkan rasa sakit di otak,

sementara NSAID seperti ibuprofen tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga mengurangi peradangan. Kedua obat ini umumnya dipilih dalam pengelolaan nyeri pada anak karena memiliki profil keamanan yang baik dan efek samping yang relatif minimal jika digunakan sesuai dosis yang dianjurkan (Gai et al., 2020).

Pada kasus nyeri yang lebih berat atau nyeri setelah prosedur pembedahan, opioid sering kali digunakan. Opioid bekerja dengan mengikat reseptor tertentu di sistem saraf pusat, yang dapat menurunkan persepsi nyeri secara signifikan. Namun, penggunaannya pada anak harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi efek samping yang serius seperti penurunan pernapasan, sembelit, dan risiko ketergantungan. Dosis obat-obatan ini harus sangat diperhatikan, dengan mempertimbangkan faktor usia, berat badan, serta kondisi medis anak, dan pemantauan ketat terhadap reaksi tubuh anak terhadap obat tersebut. Biasanya, penggunaan opioid dibatasi hanya untuk nyeri yang parah, dan sering digabungkan dengan obat lain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan nyeri (Dowell et al., 2022).

Pemilihan obat anti nyeri pada anak harus mempertimbangkan kondisi kesehatan anak secara keseluruhan, termasuk adanya penyakit tertentu, riwayat alergi, dan kemungkinan interaksi dengan obat lain. Secara umum, manajemen nyeri farmakologis pada anak memerlukan perhatian yang cermat, dengan penyesuaian dosis dan pemantauan berkala untuk memastikan keefektifan serta keselamatan pengobatan. Orang tua perlu mendapatkan edukasi yang komprehensif terkait hal ini, meliputi pemahaman tujuan pemberian obat, dosis, waktu, dan cara pemberian, efek samping dan deteksi dini, dan

evaluasi tingkat nyeri setelah pemberian obat. Orang tua diharapkan dapat mencatat aktivitas pemberian obat serta melaporkannya kepada tenaga kesehatan terkait (Fenske et al., 2021).

D. Strategi Non Farmakologis Dalam Manajemen Nyeri

Manajemen nyeri pada anak mencakup pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek, salah satunya adalah penggunaan strategi nonfarmakologis yang berfokus pada pengelolaan nyeri tanpa mengandalkan obat-obatan. Pendekatan ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada analgesik (obat anti nyeri), terutama bagi anak yang memiliki batasan dalam toleransi terhadap obat tertentu atau yang berisiko terhadap efek samping obat dalam jangka panjang. Teknik nonfarmakologis meliputi pendekatan secara fisik, psikologis, dan sosial yang bertujuan untuk mengurangi atau mengatasi nyeri sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak. Selain memberikan kenyamanan, metode ini juga mendukung proses penyembuhan anak secara komprehensif.

1. Intervensi fisik

a. Terapi panas dan dingin

Salah satu metode fisik yang sering diterapkan dalam pengelolaan nyeri pada anak adalah terapi dengan panas dan dingin. Terapi ini membantu mengurangi peradangan, meredakan nyeri pada otot, serta meningkatkan kenyamanan anak. Kompres dingin efektif dalam mengurangi pembengkakan dan peradangan pada area tubuh yang terluka, sedangkan kompres panas lebih bermanfaat untuk meredakan ketegangan otot dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, penggunaan panas atau dingin dapat

membantu meredakan nyeri pascaoperasi atau nyeri muskuloskeletal akibat cedera. Metode ini cukup sederhana, misalnya dengan menggunakan kain atau botol berisi air panas/dingin yang dibungkus kain, yang dapat diterapkan baik di rumah sakit maupun di rumah (Wang et al., 2022).

b. Pijat dan intervensi fisik lainnya

Pijat adalah salah satu teknik fisik yang efektif untuk mengatasi nyeri. Pijat ringan pada anak dapat merangsang sirkulasi darah, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan perasaan relaksasi. Metode ini sangat bermanfaat, terutama untuk nyeri otot atau nyeri yang berhubungan dengan stres atau kecemasan. Selain pijat, pendekatan fisik lain seperti terapi fisik yang bertujuan meningkatkan mobilitas atau memperbaiki postur tubuh juga bisa digunakan untuk membantu anak pulih dari cedera atau prosedur medis. Pijat dan terapi fisik ini tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi juga memberikan kenyamanan serta ketenangan yang sangat dibutuhkan anak dalam proses pemulihan (Field, 2019).

c. Relaksasi pernapasan

Teknik relaksasi dengan latihan pernapasan merupakan salah satu metode nonfarmakologis yang efektif untuk mengatasi nyeri pada anak, terutama yang berkaitan dengan kecemasan atau stres. Dalam pendekatan ini, anak-anak diajarkan untuk fokus pada pernapasan yang dalam dan perlahan, yang dapat membantu mengurangi kecemasan serta meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Metode seperti pernapasan diafragma atau pernapasan teratur dapat menenangkan sistem saraf, menurunkan detak

jantung, dan mengurangi sensasi nyeri. Teknik pernapasan ini dapat dilakukan dengan bantuan orang tua atau tenaga medis, dan sangat bermanfaat bagi anak-anak yang kesulitan mengungkapkan rasa sakit mereka secara verbal, karena metode ini mudah dipelajari dan diterapkan (Jyskä et al., 2023).

2. Intervensi psikologis

a. Pengalihan perhatian (distraksi)

Pengalihan perhatian merupakan salah satu teknik psikologis yang efektif dalam mengelola nyeri pada anak-anak. Dengan mengalihkan fokus anak dari rasa sakit, anak akan merasa lebih nyaman dan nyeri terasa lebih rileks. Aktivitas yang menyenangkan, seperti menonton film, mendengarkan musik, atau bermain permainan, dapat membantu anak-anak berfokus pada hal-hal yang lebih menyenangkan, sehingga mengurangi kesadaran mereka terhadap rasa sakit. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalihan perhatian dapat mengurangi persepsi nyeri, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan pengalaman positif anak selama prosedur medis. Teknik ini juga terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan anak sebelum prosedur medis atau selama masa pemulihan setelah operasi (Shen et al., 2023; Wieland, 2019).

b. *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) atau terapi perilaku kognitif adalah pendekatan psikologis yang sangat efektif dalam menangani nyeri kronis pada anak. CBT berfokus untuk membantu anak mengubah pola pikir yang dapat memperburuk persepsi mereka terhadap rasa sakit. Melalui terapi ini, anak diajarkan untuk

mengenali dan menangani pikiran atau keyakinan yang tidak realistis mengenai nyeri, serta menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan membangun. Terapi ini juga mengajarkan teknik-teknik untuk mengelola kecemasan dan stres yang muncul akibat nyeri, sehingga meningkatkan kontrol anak terhadap perasaan mereka dan respon terhadap rasa sakit. CBT terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup anak yang mengalami nyeri kronis (Lunde et al., 2024).

c. Terapi seni (*art therapy*) dan musik

Terapi seni dan musik adalah pendekatan kreatif yang sangat efektif dalam mengelola nyeri pada anak. Kegiatan seperti menggambar, melukis, atau bermain musik dapat membantu anak-anak menyalurkan perasaan mereka dan mengalihkan perhatian dari rasa sakit. Musik, khususnya, memiliki kemampuan menenangkan, dengan penelitian menunjukkan bahwa mendengarkan musik yang lembut dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan suasana hati. Terapi seni dan musik memberikan anak kesempatan untuk merasa lebih berdaya dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan, serta membantu meredakan ketegangan fisik dan emosional. Pendekatan ini juga bermanfaat dalam membantu anak mengatasi trauma atau rasa takut yang berkaitan dengan prosedur medis yang menyakitkan (Olaizola et al., 2024)

d. Manajemen nyeri dengan dukungan keluarga

Keterlibatan keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam pengelolaan nyeri pada anak. Kehadiran orang tua atau pengasuh yang memberikan dukungan emosional dapat mengurangi rasa cemas anak dan

memberikan rasa aman. Ketika orang tua terlibat langsung dalam perawatan, misalnya dengan memberikan pelukan atau berbicara dengan lembut, hal ini dapat menurunkan tingkat stres dan meningkatkan kemampuan anak untuk mentoleransi rasa sakit. Selain itu, keluarga juga berperan penting dalam membantu anak mengelola perasaan mereka selama proses pemulihan. Dukungan emosional dan fisik yang diberikan oleh keluarga dapat membantu anak merasa lebih diterima dan mengurangi perasaan terasing yang sering muncul selama proses hospitalisasi (Manuela et al., 2019; Saglik & Caglar, 2019).

e. *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR)

Pemanfaatan teknologi seperti *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR) telah menjadi inovasi yang efektif dalam pengelolaan nyeri pada anak. Melalui penggunaan headset VR, anak-anak dapat dibawa ke dunia virtual yang menarik dan imersif, yang membantu mengalihkan fokus mereka dari rasa sakit fisik yang sedang dirasakan. Teknologi ini sangat berguna untuk anak-anak yang menjalani prosedur medis invasif atau yang mengalami nyeri pascaoperasi. Penggunaan VR dapat membantu mengurangi kecemasan dan menciptakan pengalaman yang lebih positif bagi anak, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pemulihan mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki efektivitas tinggi dalam mengurangi persepsi nyeri dan meningkatkan kenyamanan anak selama prosedur medis yang menegangkan (Reed et al., 2021).

f. Edukasi dan persiapan psikologis

Pendidikan kesehatan yang tepat tentang prosedur medis dan nyeri yang akan dialami anak juga merupakan pendekatan nonfarmakologis yang sangat penting. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak tentang apa yang akan terjadi, alasan dilakukannya prosedur/tindakan, dan apa yang bisa mereka harapkan selama proses berlangsung dapat membantu mengurangi kecemasan dan rasa takut. Ketika anak merasa lebih siap dan memahami situasi, mereka akan lebih mampu menghadapi rasa sakit dengan lebih baik. Selain itu, melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan medis, dengan mempertimbangkan pilihan mereka, dapat meningkatkan rasa kontrol dan mengurangi stres yang mereka rasakan (Özsoy & Ulus, 2022; Trottier et al., 2019).

BAB 4

EDUKASI KELUARGA TENTANG MANAJEMEN NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI

A. Definisi Edukasi Orang Tua

Program edukasi kesehatan bagi orang tua selama anak dirawat di rumah sakit merupakan proses pemberian informasi, konseling, dan dukungan kepada keluarga, khususnya orang tua, terkait kondisi kesehatan anak, rencana perawatan atau tindakan medis, serta cara-cara untuk mempercepat pemulihan dan penyembuhan anak. Edukasi ini tidak hanya terbatas pada aspek medis seperti penyakit, prosedur tindakan, atau pemeriksaan diagnostik yang akan dilakukan pada anak, tetapi juga mencakup penanganan nyeri, stres, dan kecemasan yang mungkin dialami oleh anak dan keluarga selama perawatan di rumah sakit. Tujuan utama dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam perawatan anak, memberdayakan keluarga agar dapat membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan, serta membantu mereka mengembangkan kemandirian dalam menyesuaikan diri dengan kondisi anak. Selain itu, edukasi kepada orang tua bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara keluarga dan tenaga medis demi mencapai hasil pemulihan yang terbaik bagi anak (Lerret et al., 2020; Pereira et al., 2023).

Pendidikan kesehatan kepada keluarga selama hospitalisasi juga meliputi topik tentang cara merawat anak

pasca perawatan rumah sakit, misalnya identifikasi tanda gejala komplikasi yang harus diwaspadai, intervensi mandiri gejala yang muncul pasca perawatan, dan pengambilan keputusan yang tepat apabila terjadi perburukan kondisi anak atau berulangnya gejala. Edukasi ini sangat penting karena orang tua memegang peran utama dalam perawatan pemulihan anak. Apabila orang tua memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang baik terkait kondisi anak, serta cara merawat anak secara fisik dan emosional, mereka dapat berperan lebih aktif dalam perawatan anak

Proses edukasi ini juga harus mempertimbangkan faktor psikologis, yakni memberikan dukungan emosional kepada orang tua dan anak untuk membantu mereka menghadapi nyeri, stres, kecemasan, atau rasa takut yang muncul selama masa perawatan di rumah sakit. Penting bagi perawat untuk memfasilitasi komunikasi yang terbuka antara orang tua dan tenaga medis, agar orang tua dapat dengan mudah, jelas, dan tepat memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menerima edukasi kesehatan yang memadai cenderung lebih efektif dalam mengelola nyeri, stres, mengurangi kecemasan anak, dan turut aktif dalam perawatan anak (Barros et al., 2021; Lihua, 2018).

B. Tujuan Edukasi Manajemen Nyeri Anak

Tujuan utama dari edukasi orang tua mengenai manajemen nyeri adalah untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan orang tua dalam mengelola nyeri pada anak, dengan memadukan intervensi farmakologis (sesuai anjuran dokter) dan tindakan nonfarmakologis yang dapat dilakukan oleh orang tua secara mandiri. Pengetahuan yang memadai akan meningkatkan rasa percaya diri orang

tua dalam mengelola nyeri anak secara mandiri. Memahami berbagai alternatif pengobatan, efek samping yang mungkin timbul, serta cara-cara efektif untuk mengatasi nyeri sangatlah penting, agar orang tua tidak hanya fokus pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga dapat mencegah risiko komplikasi yang mungkin terjadi akibat kelalaian dalam manajemen nyeri. Edukasi ini bertujuan untuk mendorong orang tua agar lebih aktif berperan sebagai mitra dalam penanganan nyeri anak, sekaligus memperkuat kerjasama antara orang tua dan tenaga medis di rumah sakit (McNair et al., 2022).

Edukasi membantu orang tua untuk mengenali tanda-tanda nyeri pada anak yang mungkin sulit diungkapkan secara verbal. Anak-anak yang masih kecil sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, sehingga nyeri dapat terdeteksi melalui tanda non-verbal, seperti ekspresi wajah yang tegang, menangis, gelisah, atau perubahan dalam pola tidur. Dengan edukasi yang tepat, orang tua dapat menjadi lebih peka terhadap perubahan perilaku anak yang disebabkan oleh nyeri dan segera mengenali kebutuhan akan obat penghilang nyeri, pelayanan medis, atau intervensi lainnya. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh anak, tetapi juga mengurangi kecemasan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh orang tua dalam menghadapi kondisi tersebut (Fenske et al., 2021; Yang et al., 2023).

Tujuan lain dari edukasi kesehatan bagi orang tua adalah untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan keterampilan orang tua mengenai pentingnya pendekatan holistik atau komplementer dalam manajemen nyeri pada anak, termasuk penerapan strategi nonfarmakologis seperti teknik distraksi, relaksasi, dan pengelolaan stres. Edukasi ini

memberi kesempatan kepada orang tua untuk aktif terlibat dalam mengatasi nyeri anak. Orang tua dapat diajarkan berbagai teknik yang dapat dilakukan secara mandiri untuk meredakan nyeri anak, seperti latihan pernapasan dalam dengan meniup baling-baling, membacakan cerita, bermain permainan, atau menggunakan imajinasi terbimbing untuk mengalihkan perhatian anak dari rasa sakit. Pengetahuan tentang manajemen nyeri ini membantu orang tua menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung anak selama perawatan di rumah sakit (Holm et al., 2016; Piggott et al., 2021).

Edukasi mengenai manajemen nyeri dapat mengurangi kecemasan orang tua terkait penggunaan obat penghilang nyeri dan dampaknya pada anak. Beberapa orang tua merasa khawatir tentang potensi efek samping atau risiko ketergantungan pada obat analgesik. Ada juga yang khawatir obat tersebut dapat merusak organ vital seperti ginjal dan hati. Dengan penjelasan yang jelas mengenai penggunaan obat yang aman, dosis yang tepat, serta tanda-tanda efek samping yang perlu diperhatikan, orang tua akan merasa lebih yakin dan nyaman saat memberikan obat penghilang nyeri kepada anak. Edukasi semacam ini tidak hanya mengurangi rasa takut dan kebingungan orang tua, tetapi juga meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, yang sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi nyeri.

C. Metode Edukasi Manajemen Nyeri Anak

Edukasi orang tua mengenai manajemen nyeri pada anak perlu dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan fleksibel agar orang tua dapat memahami berbagai aspek penting dalam penanganan nyeri pada anak. Tenaga medis dapat menggunakan berbagai metode untuk

Edukasi Manajemen Nyeri Dengan Media Elektronik Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Ibu Dalam Manajemen Nyeri Anak Selama Hospitalisasi

mengedukasi orang tua secara efektif, seperti komunikasi tatap muka, materi edukasi tertulis, demonstrasi praktis, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan yang melibatkan seluruh keluarga. Berbagai metode ini saling mendukung untuk memastikan orang tua tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam, tetapi juga keterampilan praktis dalam membantu merawat anak mereka yang mengalami nyeri.

1. Konseling dan komunikasi secara langsung

Metode pertama yang sangat penting dalam edukasi orang tua adalah komunikasi langsung antara tenaga medis dan orang tua. Sesi konseling pribadi dengan dokter atau perawat memungkinkan orang tua untuk mengajukan pertanyaan terkait kondisi anak dan berbagai opsi untuk mengelola nyeri yang tersedia. Komunikasi langsung ini memberi kesempatan bagi tenaga medis untuk memberikan penjelasan mendetail mengenai penggunaan obat penghilang rasa sakit, termasuk dosis, efek samping, dan waktu pemberian obat. Selain itu, orang tua dapat diberi informasi tentang cara mengenali tanda-tanda nyeri pada anak, terutama jika anak tersebut belum dapat berkomunikasi secara verbal. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan jelas dapat membantu mengurangi kecemasan orang tua serta meningkatkan pemahaman mereka tentang perawatan anak (Gadsden et al., 2016).

2. Materi edukasi dengan media tertulis dan visual

Memberikan materi edukasi dalam bentuk tulisan merupakan metode yang efektif untuk memastikan orang tua dapat mengakses informasi yang mereka perlukan kapan saja selama proses perawatan. Brosur, pamflet, atau panduan yang menjelaskan secara rinci tentang

manajemen nyeri pada anak memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diingat. Materi ini dapat mencakup topik seperti cara mengelola nyeri setelah operasi, pengaturan dosis obat, serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan anak. Selain itu, penggunaan gambar atau diagram yang menggambarkan teknik-teknik pengalihan perhatian atau perawatan fisik dapat membantu orang tua memahami konsep yang lebih kompleks secara lebih visual. Pemberian materi edukasi tertulis ini telah terbukti meningkatkan pemahaman orang tua dan mengurangi kebingungan mereka dalam merawat anak (Hurley-Wallace et al., 2019).

3. Demonstrasi, simulasi atau roleplay

Metode edukasi melalui demonstrasi, simulasi, atau roleplay memberikan kesempatan bagi orang tua untuk belajar langsung mengenai teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengelola nyeri pada anak (Rikmasari et al., 2021). Dalam pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat menunjukkan cara menerapkan terapi fisik, seperti pemberian kompres panas atau dingin, serta teknik pernapasan relaksasi yang dapat dilakukan di rumah, sehingga pengetahuan dan keterampilannya meningkat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri orang tua untuk menerapkan keterampilan tersebut pada anak mereka. Demonstrasi langsung juga penting untuk mengajarkan cara pengelolaan obat yang tepat, seperti cara menyiapkan obat dengan dosis yang benar dan bagaimana mengawasi efek sampingnya. Penelitian menunjukkan bahwa metode demonstrasi dan *roleplay* membantu meningkatkan keterampilan praktis orang tua,

sehingga mereka dapat lebih efektif mendukung proses pemulihan anak (Heni Kusumawardani et al., 2022).

4. Pemanfaatan teknologi dan aplikasi berbasis *mobilephone*

Seiring dengan perkembangan teknologi, aplikasi *mobile* dan sumber daya digital kini semakin banyak dimanfaatkan dalam edukasi kesehatan, termasuk dalam pengelolaan nyeri pada anak. Aplikasi-aplikasi ini sering kali menawarkan panduan interaktif tentang cara mengelola nyeri, video instruksi, atau pengingat jadwal pemberian obat, sehingga orang tua dapat mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Beberapa aplikasi bahkan menyediakan fitur untuk memantau tingkat nyeri anak dan memberikan rekomendasi untuk mengurangi rasa sakit. Teknologi ini sangat berguna, terutama bagi orang tua yang memiliki jadwal padat dan memerlukan akses cepat terhadap informasi secara real-time. Penggunaan teknologi dalam edukasi juga memberikan pendekatan yang lebih personal dan fleksibel, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga (Henschke et al., 2020; Kuwabara et al., 2020).

5. Pendekatan Berbasis Keluarga dan Dukungan Emosional

Pendekatan berbasis keluarga merupakan metode edukasi yang sangat penting dalam manajemen nyeri pada anak. Melibatkan seluruh anggota keluarga, seperti orang tua, saudara kandung, dan pengasuh lainnya, dalam proses edukasi dapat memperkuat dukungan sosial yang sangat dibutuhkan selama masa perawatan anak di rumah sakit. Ketika orang tua merasa didukung oleh keluarga, mereka cenderung lebih percaya diri dalam mengelola perawatan anak mereka. Selain itu, keluarga juga dapat

dilatih untuk mengenali tanda-tanda kecemasan atau stres pada anak dan cara-cara untuk menenangkannya. Dukungan emosional dari keluarga memainkan peran penting dalam mengurangi kecemasan anak dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi rasa sakit. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam edukasi dan pengelolaan nyeri anak dapat meningkatkan hasil klinis dan psikologis anak (Gaspar et al., 2022).

D. Proses Edukasi Manajemen Nyeri Anak

Proses edukasi orang tua mengenai manajemen nyeri pada anak dimulai dengan pemahaman dasar tentang nyeri, jenis-jenisnya, serta pentingnya pengelolaan yang tepat. Orang tua perlu diberikan penjelasan yang jelas mengenai konsep nyeri, terutama pada anak-anak yang mungkin belum mampu mengungkapkan rasa sakit mereka secara verbal. Pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan antara nyeri akut dan kronis, serta jenis nyeri yang dapat dialami anak selama proses perawatan atau pemulihan, sangat diperlukan (Loopstra et al., 2015). Edukasi ini memberikan dasar pengetahuan yang dibutuhkan orang tua untuk merespons nyeri anak dengan cara yang tepat dan cepat, sehingga dapat menghindari penundaan dalam penanganan yang dapat memperburuk kondisi anak.

Setelah dasar pemahaman tentang nyeri, edukasi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai pilihan pengobatan yang tersedia, baik yang bersifat farmakologis maupun nonfarmakologis. Orang tua perlu diberikan informasi tentang berbagai jenis obat penghilang rasa sakit

yang mungkin diresepkan, termasuk dosis, cara pemberian, dan efek samping yang perlu diwaspadai. Penjelasan mengenai pengelolaan nyeri dengan obat harus mencakup informasi tentang cara mengatasi efek samping seperti mual, pusing, atau rasa kantuk yang sering terjadi akibat penggunaan analgesik. Selain itu, orang tua juga harus diberi pemahaman mengenai teknik non-farmakologis yang dapat digunakan untuk meredakan nyeri anak, seperti terapi musik, pengalihan perhatian, atau teknik pernapasan (Shi & Wu, 2023). Metode edukasi yang menyeluruh ini memastikan orang tua memahami berbagai opsi yang ada, serta kapan dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif.

Proses edukasi yang melibatkan demonstrasi langsung atau *roleplay* sangat efektif untuk memperdalam pemahaman orang tua mengenai cara-cara praktis dalam mengelola nyeri pada anak. Dalam sesi tersebut, tenaga medis dapat mempraktikkan teknik-teknik yang dapat meredakan rasa sakit, seperti penggunaan kompres panas atau dingin, serta metode pengalihan perhatian seperti bermain atau mendongeng (Alhidayat & Latif, 2022). Demonstrasi ini memberikan kesempatan bagi orang tua untuk belajar secara langsung dan mengajukan pertanyaan terkait keraguan mereka. Dengan adanya demonstrasi, orang tua merasa lebih siap dan percaya diri untuk menerapkan teknik-teknik tersebut saat merawat anak, baik di rumah sakit maupun setelah pulang ke rumah. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menerima pelatihan praktis cenderung lebih efektif dalam membantu anak mengatasi nyeri.

Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi tentang cara mengenali tanda-tanda nyeri pada anak yang belum dapat mengungkapkannya secara verbal, seperti bayi atau anak-anak yang lebih muda. Orang tua perlu diberi informasi mengenai perilaku atau perubahan fisik yang mungkin menunjukkan bahwa anak sedang merasakan nyeri, seperti perubahan pola tidur, nafsu makan, atau tingkat kecemasan. Menyadari tanda-tanda tersebut memungkinkan orang tua untuk memberikan penanganan yang tepat dan cepat, baik dengan memberikan obat atau menerapkan teknik non-farmakologis. Pemahaman ini membantu orang tua lebih peka terhadap kebutuhan anak mereka dan lebih tanggap dalam merespons nyeri yang dialami anak, yang penting untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu.

Proses edukasi ditutup dengan pemberian dukungan emosional kepada orang tua, khususnya dalam mengatasi kecemasan atau kekhawatiran mereka terkait pengelolaan nyeri pada anak. Banyak orang tua merasa khawatir tentang penggunaan obat pereda nyeri dan dampaknya terhadap anak, atau merasa tidak mampu mengelola nyeri anak dengan baik. Edukasi juga mencakup informasi tentang kapan orang tua perlu menghubungi tenaga medis jika nyeri anak tidak terkendali atau jika muncul gejala komplikasi. Dukungan emosional yang diberikan oleh tenaga medis selama proses edukasi berperan penting dalam mengurangi kecemasan orang tua dan meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam merawat anak. Di samping itu, keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam proses edukasi dapat memperkuat rasa dukungan dan meningkatkan efektivitas manajemen nyeri jangka panjang untuk anak (Zhu, 2023).

BAB 5

MEDIA ELEKTRONIK “*KIDS PAIN CARE* MANAJEMEN NYERI PADA ANAK SELAMA HOSPITALISASI: PANDUAN BAGI ORANG TUA”

A. Definisi Media Elektronik

1. Definisi media elektronik

Media elektronik, atau yang sering disebut media digital, merupakan versi digital dari materi pembelajaran yang disajikan dalam format yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar. Buku ini umumnya memuat informasi dalam bentuk teks, gambar, dan elemen multimedia lainnya yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu topik (Aminu, 2023). Dalam konteks pendidikan kesehatan, misalnya terkait dengan manajemen nyeri pada anak, booklet elektronik digunakan untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada orang tua, pasien, atau tenaga medis secara interaktif dan mudah diakses. Salah satu keuntungan utama dari booklet elektronik adalah kemampuannya untuk didistribusikan secara luas, hemat biaya, serta mudah diperbarui dengan informasi yang terbaru.

2. Tujuan media elektronik

Tujuan utama dari penggunaan media elektronik adalah untuk kemudahan akses dan efisiensi terhadap informasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bagi orang tua yang memiliki anak yang sedang dirawat di rumah sakit, media digital menyediakan informasi yang berguna mengenai perawatan nyeri pada anak, cara mengenali gejala nyeri, serta pilihan tindakan mandiri yang dapat dilakukan oleh orang tua. Booklet elektronik memungkinkan orang tua untuk menyimpan dan mengakses informasi kapan saja tanpa perlu mencari materi cetak, yang meningkatkan efektivitas dalam proses belajar dan mendapatkan informasi (Chambers et al., 1997; Kuwabara et al., 2020).

3. Karakteristik media elektronik

Media elektronik memiliki sejumlah fitur yang membedakannya dari media konvensional. Pertama, dalam format digital, media ini dapat menggabungkan berbagai jenis media, seperti teks, gambar, audio, dan video, yang menjadikannya lebih menarik dan mudah dipahami. Kedua, sifat interaktif dari media elektronik memungkinkan pengguna untuk mengklik tautan guna mengakses informasi lebih lanjut, mengisi survei, atau menonton tutorial. Ketiga, keunggulan penting lainnya adalah kemampuan untuk memperbarui materi dengan mudah, sehingga informasi yang disajikan selalu terkini tanpa perlu mencetak ulang. Keempat, dengan adanya aplikasi dan platform berbasis *cloud*, media elektronik dapat diakses secara global, mempermudah distribusi dan berbagi informasi kepada audiens yang lebih luas.

(Abdulrahman et al., 2020). Fitur-fitur ini sangat penting dalam konteks pendidikan kesehatan, di mana akurasi dan keterkinian informasi sangat diperlukan.

4. Tantangan dan pengembangan media elektronik

Meskipun media elektronik memiliki berbagai manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pentingnya memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami oleh berbagai kalangan audiens, termasuk orang tua dengan tingkat pendidikan yang beragam. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang sederhana dan gambar yang mudah dimengerti sangat diperlukan. Selain itu, meskipun banyak orang tua kini memiliki akses ke perangkat elektronik, tidak semua memiliki keterampilan teknis yang cukup untuk menggunakan teknologi ini dengan optimal (Kington et al., 2021). Oleh karena itu, dalam pengembangan booklet elektronik, perlu diperhatikan aspek kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, serta memberikan petunjuk atau pelatihan bagi orang tua tentang cara memanfaatkan media tersebut.

B. Manfaat Media Elektronik

Booklet elektronik memberikan banyak manfaat dalam pendidikan kesehatan, khususnya bagi orang tua yang anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Dengan menggunakan booklet ini, orang tua dapat belajar secara fleksibel dan terstruktur tentang manajemen nyeri pada anak, tanpa terbatas oleh waktu atau tempat. Selain itu, booklet elektronik dapat mencakup berbagai topik relevan dalam satu platform, seperti teknik pengelolaan nyeri

nonfarmakologis, efek samping obat, dan cara mendukung anak secara emosional selama proses perawatan (Hunter et al., 2019). Kemudahan akses dan pemahaman materi ini dapat membantu mengurangi kecemasan orang tua serta meningkatkan kepatuhan mereka terhadap prosedur perawatan yang diberikan.

C. Isi Media Elektronik “*Kids Pain Care* Manajemen Nyeri Pada Anak Selama Hospitalisasi: Panduan Bagi Orang Tua”

Media edukasi “E-Booklet *Kids Pain Care* Manajemen Nyeri Pada Anak Selama Hospitalisasi: Panduan Bagi orang Tua” yang dikembangkan oleh peneliti meliputi pendahuluan, definisi nyeri, penyebab nyeri, mengenali nyeri, mengukur nyeri, terapi obat, tindakan tanpa obat, simpulan, penutup, referensi, dan tim penulis. Booklet telah mendapatkan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan nomor EC002024246966. Berikut ini akan ditampilkan isi booklet, yang telah diteliti efektif untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik ibu dalam manajemen nyeri anak selama hospitalisasi.

1. Pendahuluan

PENDAHULUAN

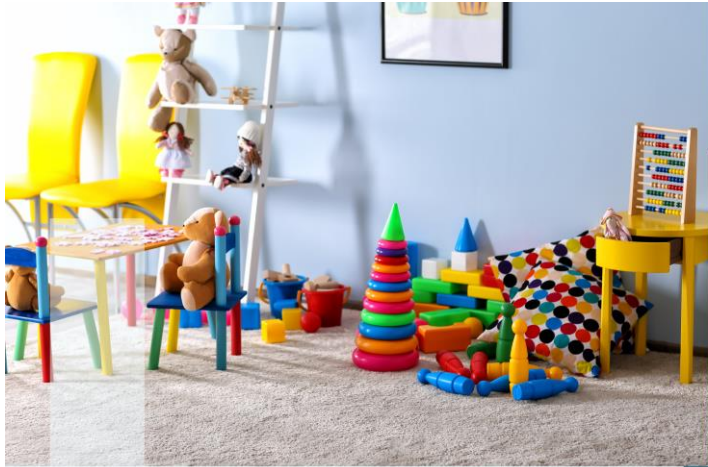
Hospitalisasi merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan anak harus menjalani perawatan di rumah sakit, akibat cedera/injuri, pemeriksaan tertentu, penyakit akut, maupun penyakit kronis. Anak berisiko mengalami stres fisik maupun psikologis akibat dari prosedur yang menyebabkan ketidaknyamanan (nyeri, rasa takut, lingkungan yang asing, kehilangan kendali atas diri sendiri). Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa nyeri akut merupakan keluhan yang paling banyak terjadi pada pasien anak yang dirawat di rumah sakit, dengan intensitas nyeri sedang hingga berat.

Nyeri yang tidak terkontrol dengan baik memberikan dampak negatif bagi anak yang menjalani hospitalisasi. Tatalaksana nyeri yang efektif sangat penting, yaitu dengan kombinasi farmakologis (obat pereda nyeri) dan non-farmakologis (tindakan tanpa obat). Tatalaksana nyeri pada anak keterlibatan orang tua, terutama ibu. Oleh karena itu, penting bagi ibu untuk mengetahui, memahami, dan mempraktikkan strategi menurunkan nyeri pada anak selama hospitalisasi. E-Booklet "Kids Pain Care" ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik ibu dalam manajemen nyeri anak.



Gambar 5.1 Pendahuluan dalam booklet elektronik

2. Definisi Nyeri



DEFINISI

Nyeri adalah perasaan ketidaknyamanan, yang berasal dari berbagai kondisi, misalnya : cedera fisik, kerusakan jaringan tubuh, prosedur medis, atau karena penyakit. Nyeri dapat dialami oleh bayi, anak, dan remaja.

Nyeri pada anak dapat bervariasi dari yang ringan hingga yang sangat berat. Pengalaman nyeri dipengaruhi oleh usia, tingkat perkembangan, serta faktor psikososial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang tepat dan pengelolaan yang efektif guna mencegah dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak

Gambar 5.2 Definisi dalam booklet elektronik

3. Penyebab Nyeri

PENYEBAB NYERI

Banyak hal yang menyebabkan nyeri. Cedera adalah penyebab paling umum nyeri pada anak. Prosedur dan perawatan medis dapat menimbulkan rasa sakit. Pembedahan (operasi) menyebabkan nyeri. Beberapa penyakit juga dapat menyebabkan nyeri.



**Pemeriksaan
Darah**



Operasi



Patah Tulang



**Terapi
Intravena**



Penyakit

Gambar 5.3 Penyebab nyeri dalam booklet elektronik

4. Mengenal Nyeri

MENGENALI DAN MENILAI NYERI PADA ANAK

Ada tiga cara untuk mengetahui seberapa besar rasa sakit yang dialami anak:



Tanyakan keluhan anak

Amati perubahan perilaku anak



Amati bagaimana reaksi tubuh anak



Gambar 5.4 Mengenal dan menilai nyeri pada anak dalam booklet elektronik

5. Mengukur Nyeri

MENGUKUR TINGKAT NYERI PADA ANAK

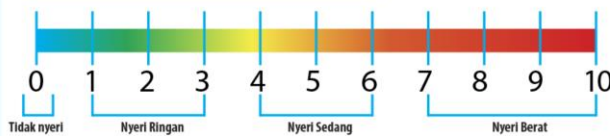
Skala Wajah



Laporan anak secara verbal



Numeric Rating Scale (NRS)



www.perawatpicu.com

MENGUKUR TINGKAT NYERI PADA ANAK

Anak Usia 3 Tahun atau Kurang

PENGKAJIAN NYERI FLACC				
OBSERVASI	KRITERIA SKORING			SKOR HASIL OBSERVASI
	0	1	2	
<i>Face</i> (Ekspresi muka)	Tidak ada ekspresi yang khusus atau tersenyum	Kadang kala meringis atau mengerutkan dahi, menarik diri	Sering mengerutkan dahi secara terus menerus, mengatupkan rahang dagu bergetar	
<i>Legs</i> (Gerakan kaki)	Posisi normal atau rileks	Tidak tenang, gelisah, tegang	Menendang atau menarik diri	
<i>Activity</i> (aktivitas)	Berbaring tenang, posisi normal, bergerak dengan mudah	Mengeliat-geliat, bolak-balik berpindah, tegang.	Melengkung, kaku, atau terus menyentak	
<i>Cry</i> (Menangis)	Tidak menangis (terjaga atau tidur)	Merintih atau merengek, kadangkala mengeluh	Menangis terus menerus, berteriak atau terisak-isak, sering mengeluh	
<i>Consolability</i> (Kemampuan rileks dihibur)	Senang, rileks	Ditenangkan dengan sentuhan sesekali, pelukan atau berbicara dapat dialihkan	Sulit untuk dihibur atau sulit untuk nyaman	
Total skor				

Interpretasi total skor(berikan tanda √ pada kategori nyeri yang sesuai) :

- ☐ 0 (rileks dan nyaman)
- ☐ 1-3 (nyeri ringan/ketidaknyamanan ringan)
- ☐ 4-6 (nyeri sedang)
- ☐ 7-10 (nyeri berat / ketidaknyamanan berat)

Gambar 5.5 Mengukur tingkat nyeri pada anak dalam booklet elektronik

6. Terapi Obat



Gambar 5.6 Terapi obat untuk nyeri pada anak dalam booklet elektronik

7. Tindakan Tanpa Obat

TINDAKAN MENGURANGI NYERI TANPA OBAT (NONFARMAKOLOGIS)

1

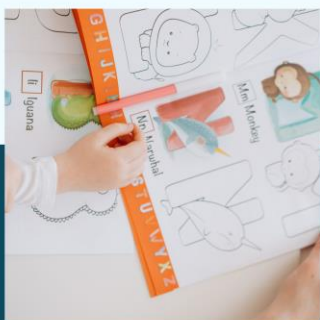
TINDAKAN PSIKOLOGIS

Tindakan psikologis untuk mengurangi nyeri antara lain : distraksi (pengalihan perhatian anak dengan membacakan cerita, video game, dll), teknik relaksasi latihan nafas, terapi musik, imajinasi terbimbing, dan bermain

2

TINDAKAN FISIK

Tindakan fisik untuk mengurangi nyeri antara lain : pengaturan posisi, pijat (massage), kompres hangat/dingin, sentuhan yang nyaman, dan lain-lain.



Gambar 5.7 Tindakan mengurangi nyeri tanpa obat dalam booklet elektronik

TINDAKAN MENGURANGI NYERI TANPA OBAT (NONFARMAKOLOGIS)

1

Kehadiran orang tua atau orang terdekat lainnya. Anak-anak sering kali merasa lebih aman dan nyaman dengan kehadiran orang tua mereka.

Berikan **informasi** yang sederhana dan akurat tentang apa yang akan terjadi. Jelaskan hal-hal secara perlahan, dengan bahasa sederhana dan ulangi sesering yang diperlukan.

2

3

Anak harus dibantu untuk **bertanya** dan **mengekspresikan perasaan** atau rasa nyeri yang dirasakannya.



TINDAKAN MENGURANGI NYERI TANPA OBAT (NONFARMAKOLOGIS)

4

Berikan anak beberapa **kendali/pilihan** atas pengobatan. Sebagai contoh, seorang anak yang memutuskan apakah akan duduk di kursi atau di pangkuan ibu ketika disuntik. Hal ini akan memberikan kenyamanan bagi anak dan mengurangi nyeri.

Ajarkan anak untuk melakukan **latihan nafas dalam** ketika merasakan nyeri. Hal ini dapat mengurangi nyeri dan meningkatkan kontrol diri anak.

5

6

Alihkan perhatian anak (teknik distraksi) dari rasa sakit. Membacakan cerita, video game, latihan pernapasan, meniup gelembung, televisi, musik, buku pop-up, membaca dan menggambar adalah contoh aktivitas pengalihan perhatian anak.



TINDAKAN MENGURANGI NYERI TANPA OBAT (NONFARMAKOLOGIS)

7

Gunakan **imajinasi** anak untuk mengubah cemas dan takut menjadi rileks dan tenang. Ibu dapat membantu dengan memusatkan perhatian anak pada aktivitas yang sudah dikenalnya, atau menceritakan/membacakan cerita yang disukai anak.

Gunakan **sugesti** untuk menghilangkan rasa sakit seperti, *"Biarkan rasa sakitnya mengalir begitu saja ke bawah dan keluar dari tubuhmu ke tempat tidur dan pergi... bagus... cukup, lepaskan saja."* Gunakan bahasa yang dipahami anak dan kegiatan atau pengalaman favorit anak

8

9

Bermain atau bercanda (humor). Anak menjadi rileks dan melupakan kekhawatiran atau nyeri mereka saat bermain.

PLAY

TINDAKAN MENGURANGI NYERI TANPA OBAT (NONFARMAKOLOGIS)

10

Sentuhan yang menenangkan. Hal ini termasuk membelai, membedong, menggendong, mengayun, membelai, memeluk, dan memijat. Memeluk anak adalah obat pereda nyeri alami.

Kompres panas, dingin, dan pemberian getaran dapat meredakan rasa sakit. Es yang dibungkus dengan kain dapat meringankan beberapa penyakit dan rasa sakit akibat prosedur. Panas berguna untuk nyeri otot. Getaran, baik dengan ketukan lembut atau metode mekanis lainnya, dapat mencegah rasa sakit.

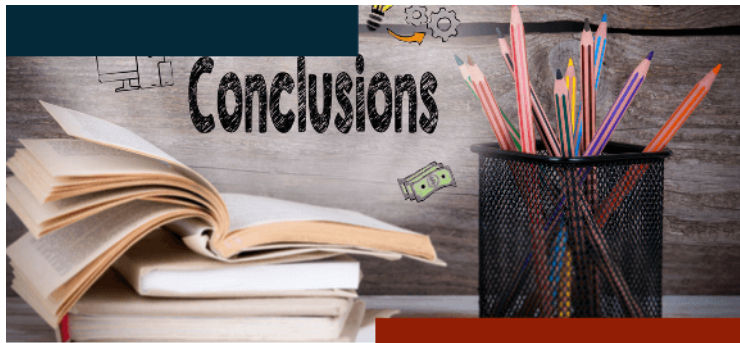
11

12

Afirmasi positif. Katakan hal positif kepada anak, misalnya “kamu hebat”, “kamu anak pemberani.”



8. Simpulan



SIMPULAN

Nyeri pada anak yang menjalani perawatan di rumah sakit disebabkan karena berbagai hal. Nyeri harus diatasi dengan baik agar tidak menyebabkan komplikasi lain. Orang tua diharapkan berpartisipasi dalam manajemen atau tatalaksana nyeri, mulai dari mengenali/menilai nyeri, mengukur tingkat nyeri, dan melakukan tindakan mandiri untuk mengurangi nyeri.

Gambar 5.8 Simpulan dalam booklet elektronik

BAB 6

PARTISIPASI ORANG TUA DALAM MANAJEMEN NYERI ANAK SELAMA HOSPITALISASI

A. Pengetahuan Orang Tua Tentang Manajemen Nyeri Anak

Pengetahuan orang tua mengenai manajemen nyeri pada anak sangat bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan akses terhadap informasi kesehatan. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun orang tua umumnya memahami pentingnya pengelolaan nyeri, banyak yang tidak sepenuhnya mengetahui cara yang tepat untuk mengatasi nyeri pada anak. Dalam banyak kasus, orang tua cenderung memilih metode yang lebih sederhana atau tradisional, seperti memberikan obat-obatan tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis, atau tidak menyadari adanya alternatif non-farmakologis, seperti teknik relaksasi atau penggunaan distraksi untuk meredakan nyeri. Hal ini mengindikasikan adanya kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola nyeri dengan cara yang efektif, yang dapat mempengaruhi kenyamanan anak.

Penelitian juga menunjukkan bahwa informasi yang diterima oleh orang tua mengenai manajemen nyeri sering kali tidak lengkap atau tidak disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Banyak orang tua merasa bahwa mereka tidak mendapatkan penjelasan yang cukup jelas mengenai efek samping obat, cara memantau nyeri, atau gejala

komplikasi yang perlu diperhatikan. Karena itu, penting untuk menyediakan pendidikan kesehatan yang lebih terorganisir dan mudah diakses, agar orang tua lebih memahami berbagai pilihan untuk mengelola nyeri. Sumber informasi seperti booklet elektronik atau platform digital lainnya dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini, memberikan penjelasan yang lebih komprehensif, serta mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam merawat anak mereka.

Penggunaan media elektronik tentang manajemen nyeri anak dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan orang tua terkait cara mengatasi nyeri pada anak. Media elektronik ini menyediakan informasi yang mudah dipahami mengenai berbagai metode pengelolaan nyeri, baik yang melibatkan obat-obatan maupun yang tidak, serta potensi efek samping dari pilihan pengobatan yang ada. Orang tua yang menerima media elektronik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara mengidentifikasi gejala nyeri pada anak, memilih metode pengelolaan yang tepat, dan kapan sebaiknya mencari pertolongan medis. Dengan akses informasi yang lebih terstruktur dan mudah dijangkau, orang tua merasa lebih yakin dalam menangani nyeri anak mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa media elektronik dapat membuat orang tua merasa lebih terlibat dalam perawatan anak mereka serta mengurangi kecemasan terkait pengelolaan nyeri. Selain memberikan informasi tentang pengobatan, media ini juga memberikan panduan praktis mengenai cara mendukung anak secara emosional selama masa perawatan. Orang tua yang menggunakan media elektronik melaporkan peningkatan pengetahuan

mengenai teknik-teknik pengelolaan nyeri non-obat, seperti distraksi atau relaksasi, yang dapat digunakan untuk membantu mengurangi rasa sakit. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan orang tua terhadap pengobatan yang diberikan dan memperbaiki kenyamanan serta kesejahteraan anak dalam menjalani proses perawatan.

B. Sikap Orang Tua Dalam Manajemen Nyeri Anak

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik mengenai manajemen nyeri anak dapat membawa perubahan positif dalam sikap orang tua terhadap pengelolaan nyeri selama anak dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, orang tua yang mungkin kurang mengetahui cara yang tepat untuk menangani nyeri, menjadi lebih percaya diri dalam memilih pengobatan yang tepat dan metode non-farmakologis. Dengan informasi yang mudah dipahami dan praktis dalam media elektronik, orang tua merasa lebih siap untuk membantu anak mereka menggunakan teknik pengelolaan nyeri seperti relaksasi, distraksi, dan pemberian obat sesuai anjuran medis. Peningkatan pengetahuan ini membuat mereka merasa lebih terlibat dalam perawatan dan tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga medis, yang akhirnya meningkatkan rasa kontrol dan kepuasan terhadap perawatan yang diterima oleh anak.

Selain itu, setelah menerima media elektronik, sikap orang tua menjadi lebih proaktif dalam mengelola nyeri anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua dengan akses informasi yang lebih baik cenderung lebih aktif memantau kondisi anak mereka dan bertanya kepada tenaga medis terkait pengelolaan nyeri. Mereka juga lebih terbuka terhadap penggunaan metode non-obat dan lebih sadar

akan pentingnya dukungan emosional bagi anak. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya manajemen nyeri, orang tua tidak hanya mengurangi kecemasan mereka sendiri, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup anak selama perawatan di rumah sakit.

C. Praktik Orang Tua Dalam Manajemen Nyeri Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menerima media elektronik tentang manajemen nyeri pada anak, praktik orang tua dalam mengelola nyeri selama perawatan di rumah sakit mengalami peningkatan yang jelas. Orang tua yang sebelumnya mungkin kurang memahami cara yang tepat untuk menangani nyeri, kini lebih mahir dalam mengenali tanda-tanda nyeri dan memilih tindakan yang sesuai. Dengan informasi yang disajikan secara jelas dan praktis dalam media elektronik, mereka menjadi lebih proaktif dalam mengurangi nyeri, baik dengan memberikan obat-obatan yang direkomendasikan oleh tenaga medis, maupun menerapkan metode non-farmakologis seperti teknik relaksasi dan distraksi. Peningkatan keterampilan ini membuat orang tua merasa lebih yakin dalam mendampingi anak mereka selama perawatan, serta membantu memastikan pengelolaan nyeri yang lebih efektif.

Orang tua juga semakin terlibat dalam komunikasi dengan tim medis setelah menerima media elektronik. Mereka lebih aktif dalam mendiskusikan gejala nyeri yang dialami anak dan menanyakan pilihan pengelolaan nyeri yang lebih tepat. Praktik orang tua dalam memantau nyeri anak dan melaporkannya kepada tenaga medis pun semakin meningkat, memungkinkan penyesuaian pengobatan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi anak. Dengan

pengetahuan yang lebih mendalam dan pendekatan yang lebih terarah, orang tua dapat lebih efektif dalam mengelola nyeri anak mereka, yang berdampak positif pada kenyamanan anak dan membantu mempercepat proses pemulihan selama masa perawatan di rumah sakit.

D. Partisipasi Orang Tua dalam Manajemen Nyeri Anak

1. Pentingnya Peran Orang Tua dalam Manajemen Nyeri pada Anak

Peran serta orang tua dalam pengelolaan nyeri pada anak yang dirawat di rumah sakit sangat krusial karena dapat mempengaruhi efektivitas penatalaksanaan nyeri dan proses pemulihan anak. Sebagai pemberi asuhan yang utama, orang tua memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan dan perilaku anak, yang sangat berguna dalam mendeteksi tanda-tanda nyeri, terutama pada anak-anak yang belum mampu mengungkapkan rasa sakit mereka secara verbal (Claridge et al., 2020). Orang tua juga dapat bertindak sebagai penghubung antara anak dan tenaga kesehatan, memastikan kebutuhan terkait pengelolaan nyeri anak segera ditangani. Keterlibatan orang tua dalam pengelolaan nyeri, baik yang bersifat farmakologis maupun nonfarmakologis, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak secara menyeluruh dan memberikan kenyamanan selama perawatan (Jerofke-Owen et al., 2022).

2. Identifikasi dan Pengelolaan Nyeri

Salah satu cara orang tua berpartisipasi adalah dengan mengidentifikasi dan menyampaikan tingkat nyeri yang dirasakan anak. Mayoritas anak, terutama yang

masih kecil atau memiliki kesulitan dalam berkomunikasi, gejala nyeri sering kali tidak disampaikan secara langsung (verbal). Orang tua yang lebih paham terhadap perubahan perilaku atau tanda fisik anak, dapat memberikan informasi penting kepada tenaga medis mengenai intensitas dan jenis nyeri yang dialami anak. Sebagai contoh, perubahan dalam pola tidur, nafsu makan, atau tingkat kecemasan anak bisa menjadi petunjuk yang membantu tenaga kesehatan dalam menentukan perawatan yang paling sesuai (Harrison et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam memantau nyeri anak dapat mempercepat proses diagnosis dan meningkatkan akurasi tatalaksana nyeri yang diprogramkan.

3. Pengelolaan Nyeri Farmakologis

Keterlibatan orang tua dalam pengelolaan nyeri anak juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang penggunaan obat penghilang rasa sakit yang diresepkan. Pendidikan tentang cara penggunaan analgesik, termasuk dosis, frekuensi, dan potensi efek samping, membuat orang tua merasa lebih percaya diri dalam mengelola nyeri anak mereka. Orang tua yang memahami dengan jelas bagaimana mengatur pemberian obat dan memantau efek sampingnya dapat lebih efektif dalam menangani nyeri anak tanpa harus menunggu intervensi dari tenaga medis. Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang diberikan informasi lengkap tentang pengelolaan nyeri melalui obat-obatan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap regimen pengobatan, yang berkontribusi pada pengendalian nyeri yang lebih baik.

4. Pengelolaan Nyeri Nonfarmakologis

Selain intervensi obat-obatan, orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan nyeri non-farmakologis. Berbagai metode seperti teknik relaksasi, pengalihan perhatian, atau penggunaan musik untuk menenangkan anak, dapat diterapkan oleh orang tua untuk membantu meredakan nyeri (Yang et al., 2023). Orang tua yang terlatih dalam teknik-teknik ini mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan mendukung proses pemulihan anak. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan non-farmakologis yang didukung oleh keterlibatan orang tua terbukti efektif dalam mengurangi kecemasan dan rasa sakit pada anak, serta meningkatkan kenyamanan emosional mereka selama perawatan.

5. Dukungan Emosional untuk Anak

Dukungan emosional dari orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan nyeri pada anak. Ketika anak merasa aman dan nyaman secara emosional, mereka lebih mampu menghadapi rasa sakit dengan lebih baik. Kehadiran orang tua, memberikan kenyamanan fisik seperti pelukan atau memegang tangan, serta berbicara dengan lembut dapat membantu mengurangi kecemasan anak (Handayani & Daulima, 2020). Selain itu, orang tua dapat mengajarkan anak teknik-teknik untuk mengatasi rasa sakit, seperti pernapasan dalam atau visualisasi, yang dapat membantu anak merasa lebih memiliki kendali atas keadaan mereka. Keterlibatan emosional orang tua sangat mempengaruhi suasana hati anak, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pemulihan dan mengurangi persepsi nyeri.

6. Pemberdayaan Orang Tua melalui Edukasi

Pendidikan kesehatan tentang manajemen nyeri bagi orang tua sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses perawatan anak. Tenaga kesehatan dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai cara mengidentifikasi tanda-tanda nyeri pada anak, berbagai teknik untuk mengelola nyeri, serta kapan sebaiknya meminta bantuan profesional. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai opsi pengobatan, baik yang melibatkan obat-obatan maupun pendekatan non-farmakologis, orang tua dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait perawatan anak mereka. Selain itu, edukasi tentang pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi untuk memantau tingkat nyeri atau pengingat untuk pemberian obat, dapat mempermudah orang tua dalam menjalankan peran mereka dalam pengelolaan nyeri (M. Said & R. Mohamed, 2022).

7. Pentingnya Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan

Keterlibatan orang tua dalam pengelolaan nyeri juga melibatkan kerjasama yang erat dengan tenaga medis. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa perawatan nyeri yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak (Ashcraft et al., 2019; Yang et al., 2023). Orang tua yang merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengobatan dan perawatan anak mereka cenderung lebih puas dengan proses perawatan serta memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah. Kolaborasi ini menciptakan rasa tanggung

jawab bersama antara orang tua dan tenaga medis, yang pada gilirannya mendukung pendekatan perawatan yang lebih holistik dan efektif (Sundal & Vatne, 2020). Ini menunjukkan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk bertanya atau memberikan masukan terkait manajemen nyeri anak mereka.

BAB 7

PENUTUP

Hasil penelitian yang dibahas dalam monograf ini menyimpulkan bahwa penerapan media edukasi elektronik dalam manajemen nyeri anak selama masa hospitalisasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua dalam berpartisipasi menangani nyeri anak. Sebagai sarana edukasi yang dapat diakses dengan mudah, booklet elektronik menyajikan informasi yang terorganisir dengan baik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan orang tua. Ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami berbagai metode pengelolaan nyeri, baik melalui obat-obatan maupun teknik nonfarmakologis, serta membantu dalam mengenali gejala nyeri pada anak dengan lebih efektif. Dengan demikian, media elektronik berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan oleh orang tua selama perawatan anak di rumah sakit.

Media elektronik juga berkontribusi pada perubahan positif dalam sikap orang tua terkait pengelolaan nyeri. Orang tua yang memperoleh edukasi melalui media elektronik cenderung merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan tentang perawatan anak mereka. Peningkatan pemahaman tentang cara mengelola nyeri secara tepat dan kapan sebaiknya meminta bantuan medis membuat orang tua lebih aktif berpartisipasi dalam perawatan anak mereka. Sikap yang lebih proaktif ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan emosional anak, tetapi juga mendukung pemulihan yang lebih cepat. Oleh karena itu, pentingnya informasi yang jelas dan mudah diakses

bagi orang tua dalam meningkatkan kepatuhan mereka terhadap pengelolaan nyeri tidak dapat diragukan.

Selain itu, praktik orang tua dalam mengelola nyeri anak juga mengalami peningkatan yang signifikan setelah mereka menerima edukasi dengan media elektronik. Orang tua yang dilengkapi dengan informasi yang memadai mengenai pengobatan dan teknik non-obat, seperti teknik relaksasi atau distraksi, dapat merespons dengan lebih cepat terhadap kebutuhan anak. Mereka menjadi lebih efektif dalam mengelola nyeri melalui pemberian obat yang tepat atau penerapan strategi non-farmakologis yang mendukung kenyamanan anak. Peningkatan keterampilan ini, yang diperoleh melalui edukasi yang baik, berperan besar dalam pengelolaan nyeri yang lebih optimal dan mempercepat pemulihan anak selama perawatan di rumah sakit.

Secara keseluruhan, media elektronik sebagai media edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua terkait manajemen nyeri anak. Meski demikian, masih terdapat tantangan terkait dengan aksesibilitas teknologi dan tingkat keterampilan orang tua dalam menggunakan media ini. Oleh karena itu, pengembangan media elektronik yang lebih lanjut perlu melibatkan penyediaan pelatihan atau panduan untuk orang tua, serta memastikan informasi yang disampaikan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan terkini. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan media elektronik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perawatan anak di rumah sakit, membantu meningkatkan pengelolaan nyeri dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan anak serta orang tua..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahaman, M. D., Faruk, N., Oloyede, A. A., Surajudeen-Bakinde, N. T., Olawoyin, L. A., Mejabi, O. V., Imam-Fulani, Y. O., Fahm, A. O., & Azeez, A. L. (2020). Multimedia tools in the teaching and learning processes: A systematic review. *Heliyon*, 6(11), e05312. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05312>
- Alhidayat, N. S., & Latif, A. I. (2022). the Effectiveness of the Combination of Demonstration and Role-Play Methods To Improve Knowledge About Choking Management. *Journal of Islamic Nursing*, 7(2), 50–56. <https://doi.org/10.24252/join.v7i1.32577>
- Aminu, M. (2023). *AND ELECTRONIC BASED INSTRUCTIONAL STRATEGIES FOR TEACHING SOCIAL* (Issue December).
- Andersson, V., Bergman, S., Henoch, I., Simonsson, H., & Ahlberg, K. (2022). Pain and pain management in children and adolescents receiving hospital care: a cross-sectional study from Sweden. *BMC Pediatrics*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12887-022-03319-w>
- Ashcraft, L. E., Asato, M., Houtrow, A. J., Kavalieratos, D., Miller, E., & Ray, K. N. (2019). Parent Empowerment in Pediatric Health Care Settings: A Systematic Review of Observational Studies Synthesis of results: We identified six themes within consequences of empowerment: increased parent involvement in daily care, improved symptom management, .

Patient, 12(2), 199–212.
<https://doi.org/10.1007/s40271-018-0336-2>.Parent

Barros, I., Lourenço, M., Nunes, E., & Charepe, Z. (2021). Nursing Interventions Promoting Child / Youth / Family Adaptation to Hospitalization: A Scoping Review. *Enfermeria Global*, 20(1), 577–596.
<https://doi.org/10.6018/eglobal.413211>

Bortolote, G. S., & Brêtas, J. R. da S. (2008). The stimulating environment for the development of hospitalized children. *Revista Da Escola de Enfermagem*, 42(3), 422–428. <https://doi.org/10.1590/s0080-62342008000300002>

Burger, P., Van den Ende, E. S., Lukman, W., Burchell, G. L., Steur, L. M. H., Merten, H., Nanayakkara, P. W. B., & Gemke, R. J. B. J. (2022). Sleep in hospitalized pediatric and adult patients – A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine: X*, 4, 100059.
<https://doi.org/10.1016/j.sleepx.2022.100059>

Buyukgonenc, L., & Toruner, E. . (2021). Çocukluk Yaşlarında Ağrı ve Hemşirelik Yönetimi. [Pain and Nursing Management in Childhood Ages]. In *Pediatric Hemşireliği* , [Pediatric Nursing]. Akademisyen Publisher.

Carvalho, J. A., de Souza, D. M., Domingues, F., Amatuzzi, E., Pinto, M. C. M., & Rossato, L. M. (2022). Pain management in hospitalized children: A cross-sectional study*. *Revista Da Escola de Enfermagem*, 56, 1–9. <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0008en>

Cetinkaya, S. (2023). Pain Management in Pediatric Nursing.

- Open Journal of Pediatrics*, 13(03), 379–393.
<https://doi.org/10.4236/ojped.2023.133043>
- Chambers, C. T., Reid, G. J., McGrath, P. J., Finley, G. A., & Ellerton, M. Lou. (1997). A Randomized Trial of a Pain Education Booklet: Effects on Parents' Attitudes and Postoperative Pain Management. *Children's Health Care*, 26(1), 1–13.
https://doi.org/10.1207/s15326888chc2601_1
- Chumpitazi, C. E., Chang, C., Atanelov, Z., Dietrich, A. M., Lam, S. H. F., Rose, E., Ruttan, T., Shahid, S., Stoner, M. J., Sulton, C., & Saidinejad, M. (2022). Managing acute pain in children presenting to the emergency department without opioids. *JACEP Open*, 3(2), 1–9.
<https://doi.org/10.1002/emp2.12664>
- Claridge, A. M., Hajec, L. P., Montgomery, L. P., & Knapp, B. M. (2020). *Child and Parent Psychosocial Experiences of Hospitalization: An Examination of the Role of Child Life Specialists* (Vol. 1, Issue 1).
- Claridge, A. M., & J Powell, O. (2022). Children's experiences of stress and coping during hospitalization: A mixed-methods examination. *Journal of Child Health Care*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/13674935221078060>
- Cunico, D., Rossi, A., Verdesca, M., Principi, N., & Esposito, S. (2023). Pain Management in Children Admitted to the Emergency Room: A Narrative Review. *Pharmaceuticals*, 16(8), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/ph16081178>
- De Alencar, I. G. M., Dos Santos Dantas, J. K., De Araújo, S. C. M., De Lima Fernandes, T. E., De Araújo, P. L. O., Da Costa, A. B., Takahashi, J. A., & De Oliveira, J. S. A.

- (2024). Non-pharmacological therapies for pain management in paediatric intensive care units: A protocol for a scoping review. *BMJ Open*, 14(2), 1–7. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-074952>
- De Souza, E., Parvathinathan, G., & Anderson, T. A. (2024). Pain Prevalence and Treatment in Hospitalized Children and Adolescents at a US Tertiary Pediatric Hospital. *Clinical Pediatric*, 63(6), 805–814. <https://doi.org/10.1177/00099228231196473>
- Delvecchio, E., Salcuni, S., Lis, A., Germani, A., & Di Riso, D. (2019). Hospitalized Children: Anxiety, Coping Strategies, and Pretend Play. *Frontiers in Public Health*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00250>
- Delvecchio, E., Salcuni, S., Lis, A., Germani, A., & Riso, D. Di. (2019). *Hospitalized Children: Anxiety , Coping Strategies , and Pretend Play*. 7(September), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00250>
- Dowell, D., Ragan, K. R., Jones, C. M., Baldwin, G. T., & Chou, R. (2022). Morbidity and Mortality Weekly Report CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain-United States, 2022 Centers for Disease Control and Prevention MMWR Editorial and Production Staff (Serials) MMWR Editorial Board CONTENTS. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 71(3), 1–95.
- Downey, C., & Crummy, A. (2022). The impact of childhood trauma on children’s wellbeing and adult behavior. *European Journal of Trauma and Dissociation*, 6(1), 100237. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100237>

- Duran, J., Bravo, L., Torres, V., Craig, A., Heidari, J., Adlard, K., Secola, R., Granados, R., & Jacob, E. (2020). Quality of Life and Pain Experienced by Children and Adolescents with Cancer at Home Following Discharge from the Hospital. *Journal of Pediatric Hematology/Oncology*, 42(1), 46–52. <https://doi.org/10.1097/MPH.0000000000001605>
- Fenske, J. ., Berland, D. ., Chandran, S., & et.al. (2021). *Pain Management*. Medicine University of Michigan.
- Ferreira, L. B., de Oliveira, J. S. ., Gonçalves, R. G., Maria, T., Elias, N., Maria De Medeiros, S., Dinorah, D., & Mororó, S. (2019). Nursing care for the families of hospitalized children and adolescents. *J Nurs UFPE Online*, 13(1), 23–31. <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v13i01a237672p23-31-2019>
- Field, T. (2019). Pediatric massage therapy research: A narrative review. *Children*, 6(6), 1–12. <https://doi.org/10.3390/children6060078>
- Friedrichsdorf, S. J., & Goubert, L. (2020). Pediatric pain treatment and prevention for hospitalized children. *Pain Reports*, 5(1), E804. <https://doi.org/10.1097/PR9.0000000000000804>
- Friedrichsdorf, S., Postier, A., Eull, D., Weidner, C., Foster, L., & Gilbert, M. (2015). Pain outcomes in a US children's hospital: a prospective cross-sectional survey. *Hospital Pediatrics*.
- Gadsden, V. L., Ford, M., & Breiner, H. (2016). Parenting matters: Supporting parents of children ages 0-8. In *Parenting Matters: Supporting Parents of Children Ages 0-8*. <https://doi.org/10.17226/21868>

- Gai, N., Naser, B., Hanley, J., Peliowski, A., Hayes, J., & Aoyama, K. (2020). A practical guide to acute pain management in children. *Journal of Anesthesia*, 34(3), 421–433. <https://doi.org/10.1007/s00540-020-02767-x>
- Gaspar, T., Cerqueira, A., Guedes, F. B., & de Matos, M. G. (2022). Parental Emotional Support, Family Functioning and Children's Quality of Life. *Psychological Studies*, 67(2), 189–199. <https://doi.org/10.1007/s12646-022-00652-z>
- Handayani, A., & Daulima, N. H. C. (2020). Parental presence in the implementation of atraumatic care during children's hospitalization. *Pediatric Reports*, 12. <https://doi.org/10.4081/pr.2020.8693>
- Harrison, L. E., Timmers, I., Heathcote, L. C., Fisher, E., Tanna, V., Bans, T. D. S., & Simons, L. E. (2020). Parent responses to their child's pain: Systematic review and meta-analysis of measures. *Journal of Pediatric Psychology*, 45(3), 281–298. <https://doi.org/10.1093/JPEPSY/JSAA005>
- Heni Kusumawardani, L., Kartikasari, A., Nanda Pratama, K., & Heni Kusumawardani Soeparno Karangwangkal Purwokerto, L. (2022). Parental Knowledge Influenced the Effectiveness of Role Play on Food Safety Behavior in School-Age Children. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*, 5(2), 167–177.
- Henschke, N., Bs, B., Gl, M., Tamrat, T., Shepperd, S., Dc, G., Ar, J. M., Villanueva, G., Ms, F., Glenton, C., Lewin, S., Henschke, N., & Bs, B. (2020). *Gonçalves-Bradley DC*,

J Maria AR, Ricci-Cabello I, Villanueva G, Fønhus MS, Glenton C, Lewin S, Henschke N, Buckley BS, Mehl GL, Tamrat T, Shepperd S.
<https://doi.org/10.1002/14651858.CD012927.pub2>.
www.cochranelibrary.com

- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2015). *Wong's Nursing Care of Infants and Children* (10th edition). Elsevier Inc.
- Holm, K. E., Patterson, J. M., & Gurney, J. G. (2016). Parental Involvement and Family-Centered Care in the Diagnostic and Treatment Phases of Childhood Cancer: Results from a Qualitative Study. *Journal of Pediatric Oncology Nursing*, 20(6).
<https://doi.org/10.1177/1043454203254984>
- Hunter, J. F., Kain, Z. N., & Fortier, M. A. (2019). Pain relief in the palm of your hand: Harnessing mobile health to manage pediatric pain. *Paediatric Anaesthesia*, 29(2), 120–124. <https://doi.org/10.1111/pan.13547>
- Hurley-Wallace, A., Wood, C., Franck, L. S., Howard, R. F., & Liossi, C. (2019). Paediatric pain education for health care professionals. *Pain Reports*, 4(1), 1–5.
<https://doi.org/10.1097/PR9.0000000000000701>
- Hybschmann, J., Topperzer, M. K., Gjørde, L. K., Born, P., Mathiasen, R., Sehested, A. M., Jennum, P. J., & Sørensen, J. L. (2021). Sleep in hospitalized children and adolescents: A scoping review. *Sleep Medicine Reviews*, 59.
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2021.101496>
- Jackie, V., Joanna, S., Marilynne, N. K., & Kathleen, C. (2019). Tokenism or true partnership: Parental involvement

in a child's acute pain care. *Journal of Clinical Nursing*, 28(9–10), 1491–1505.
<https://doi.org/10.1111/jocn.14747>

Jerofke-Owen, T. A., McAndrew, N. S., Gralton, K. S., Totka, J. P., Weiss, M. E., Fial, A. V., & Sawin, K. J. (2022). Engagement of Families in the Care of Hospitalized Pediatric Patients: A Scoping Review. *Journal of Family Nursing*, 28(2), 151–171.
<https://doi.org/10.1177/10748407211048894>

Jordan, A., Carter, B., & Vasileiou, K. (2021). "Pain talk": A triadic collaboration in which nurses promote opportunities for engaging children and their parents about managing children's pain. *Paediatric and Neonatal Pain*, 3(3), 123–133.
<https://doi.org/10.1002/pne2.12061>

Jyskä, I., Turunen, M., Chaychi Maleki, A., Karppa, E., Palmu, S., Viik, J., Mäkelä, J., & Puura, K. (2023). Effects of Using Guided Deep Breathing Exercises in a Virtual Natural Environment to Reduce Stress during Pediatric Treatment. *Healthcare (Switzerland)*, 11(24).
<https://doi.org/10.3390/healthcare11243140>

Karcz, M., Abd-Elsayed, A., Chakravarthy, K., Aman, M. M., Strand, N., Malinowski, M. N., Latif, U., Dickerson, D., Suvar, T., Lubenow, T., Peskin, E., D'souza, R., Cornidez, E., Dudas, A., Lam, C., Farrell, M., Sim, G. Y., Sebai, M., Garcia, R., ... Deer, T. (2024). Pathophysiology of Pain and Mechanisms of Neuromodulation: A Narrative Review (A Neuron Project). *Journal of Pain Research*, 17(October), 3757–3790. <https://doi.org/10.2147/JPR.S475351>

- Kington, R. S., Arnesen, S., Chou, W.-Y. S., Curry, S. J., Lazer, D., & Villarruel, A. M. (2021). Identifying Credible Sources of Health Information in Social Media: Principles and Attributes. *NAM Perspectives*. <https://doi.org/10.31478/202107a>
- Kuwabara, A., Su, S., & Krauss, J. (2020). Utilizing Digital Health Technologies for Patient Education in Lifestyle Medicine. *American Journal of Lifestyle Medicine*, 14(2), 137–142. <https://doi.org/10.1177/1559827619892547>
- Lambert, T., Truong, T., & Gray, B. (2019). Pain perception with cervical tenaculum placement during intrauterine device insertion: a randomised controlled trial. *BMJ Sexual & Reproductive Health*, 46(2), 126. <https://doi.org/10.1136/bmjshr-2019-200376>
- Lassetter, J. H. (2006). The Effectiveness of Complementary Therapies on the Pain Experience of Hospitalized Children. *Journal of Holistic Nursing*, 24(3), 196–208. <https://doi.org/10.1177/0898010106289838>
- Lerret, S. M., Johnson, N. L., Polfuss, M., Weiss, M., Gralton, K., Klingbeil, C. G., Gibson, C., Garnier-Villarreal, M., Ahamed, S. I., Adib, R., Unteutsch, R., Pawela, L., White-Traut, R., & Sawin, K. (2020). Using the engaging parents in education for discharge (ePED) iPad application to improve parent discharge experience. *Journal of Pediatric Nursing*, 52, 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.02.041>
- Lihua, P. (2018). *How nurses can support hospitalized children A descriptive literature review*. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1223312/FULLTEXT01.p>

df

- Loopstra, C., Strodl, E., & Herd, D. (2015). A qualitative analysis of how parents assess acute pain in young children. *Health Psychology Open*, 2(1). <https://doi.org/10.1177/2055102914566290>
- Lulgjuraj, D., & Maneval, R. E. (2021). Unaccompanied Hospitalized Children: An Integrative Review. *Journal of Pediatric Nursing*, 56, 38–46. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.10.015>
- Lunde, C. E., Wu, Z., Reinecke, A., & Sieberg, C. B. (2024). The Application of Cognitive Behavioral Therapy for Adolescent Patients With Endometriosis: A Topical Review. *Cognitive and Behavioral Practice*, 31(3), 383–398. <https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2024.01.005>
- M. Said, K., & R. Mohamed, H. (2022). Effect of Empowerment Program on Parents' Self-Competence regarding Caring for their Children with Eye Injuries. *Egyptian Journal of Health Care*, 13(1), 1487–1505. <https://doi.org/10.21608/ejhc.2022.233429>
- Maleki, M., Mardani, A., Harding, C., Basirinezhad, M. H., & Vaismoradi, M. (2022). Nurses' strategies to provide emotional and practical support to the mothers of preterm infants in the neonatal intensive care unit: A systematic review and meta-analysis. *Women's Health*, 18. <https://doi.org/10.1177/17455057221104674>
- Manuela, F., Pierrick, P., Jérôme, M., Maria, G. M., Olivier, B., Petra, H., Grandjean, D., & Pierre, K. (2019). Pain, parental involvement, and oxytocin in the neonatal

- intensive care unit. *Frontiers in Psychology*, 10(715).
<https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00715>
- McNair, C., Chirinian, N., Uleryk, E., Stevens, B., McAllister, M., Franck, L., Taddio, A., & Shah, V. (2022). Effectiveness of parental education about pain in the neonatal period on knowledge, attitudes, and practices: A systematic review and meta-analysis. *Paediatrics & Child Health*, 27(8).
<https://doi.org/10.1093/pch/pxac050>
- Mediani, H. S., Hendrawati, S., Shidqi, N., & Suzanamediani, H. (2019). The Knowledge and Attitude of Nurses in the Implementation of Atraumatic Care in Hospitalized Children in Indonesia. *IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS)*, 8(1), 51–56.
<https://doi.org/10.9790/1959-0801075156>
- Olaizola, S., Laloo, C., Vickers, V., Kelenc, L., Tariq, S., Brown, S. C., & Stinson, J. N. (2024). Art Therapy for Paediatric Pain: A Scoping Review. *Children*, 11(6).
<https://doi.org/10.3390/children11060619>
- Özsoy, F., & Ulus, B. (2022). Comparison of Two Different Methods in Reducing Pain and Fear due to Dressing Change in 7-10 Years Old Children. *The Journal of Pediatric Research*, 9(1), 66–75.
<https://doi.org/10.4274/jpr.galenos.2021.68335>
- Palomaa, A.-K., Hakala, M., & Pölkki, T. (2023). Parents' perceptions of their child's pain assessment in hospital care: A cross-sectional study. *Journal of Pediatric Nursing*, 71(6), 79–87.
<https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.03.012>

- Palomares González, L., Hernández Caravaca, I., Gómez García, C. I., & Sánchez-Solís de Querol, M. (2023). Parental presence during invasive pediatric procedures: what does it depend on? *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 31, e3828. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6101.3828>
- Perdani, A. L., Mutiar, A., & Nazmudin, Y. (2021). The Impact of Implementation Virtual Reality (VR) on Pain Levels Among Children with Invasive Procedures: A Literature Review. *KnE Life Sciences*, 2021, 713–718. <https://doi.org/10.18502/kls.v6i1.8746>
- Pereira, A. F., Escola, J. J. J., Almeida, C. M. T., & Rodrigues, V. M. C. P. (2023). Health education provided by nurses to children and young people: parents' assessment. *BMC Nursing*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12912-023-01447-x>
- Piggott, S., Carter, S., Forrest, H., Atkinson, D., Mackean, T., Mcphee, R., & Arrow, P. (2021). Parent perceptions of minimally invasive dental treatment of Australian Aboriginal pre-school children in rural and remote communities. *Rural and Remote Health*, 21(4), 6862. <https://doi.org/10.22605/rrh6862>
- Raja S, Carr D, Cohen M, Finnerup N, Flor H, & Gibson S. (2021). The Revised IASP definition of pain: concepts, challenges, and compromises. Pain [revista en Internet] 2021 [acceso 4 de marzo de 2022]; 161(9): 1-16. *Pain*, 161(9), 1976–1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>. The
- Reed, L. A., Miller, D., & Harbour, A. (2021). Acute compartment

- syndrome resultant from alcohol abuse. *Journal of Surgical Case Reports*, 2021(4), rjab128.
<https://doi.org/10.1093/jscr/rjab128>
- Rikmasari, R., Summirat, F., & Pratiwi, F. A. (2021). Role Playing Learning Method as A Solution to Improve The Learning Outcomes of Civic Education Elementary School Students of Election and Election Materials. *Edukasi*, 15(2), 169–181.
<https://doi.org/10.15294/edukasi.v15i2.30324>
- Roessler De Angulo, N., Postier, A. C., Purser, L., Ngo, L., Sun, K., & Friedrichsdorf, S. (2024). Assessment and Treatment of Pain in Hospitalized Children at a Tertiary Children's Hospital: A Cross-Sectional Mixed Methods Survey. *Children*, 11(7).
<https://doi.org/10.3390/children11070874>
- Rokach, A. (2016a). Psychological, emotional and physical experiences of hospitalized children. *Clinical Case Reports and Reviews*, 2(4).
<https://doi.org/10.15761/ccrr.1000227>
- Rokach, A. (2016b). *Psychological , emotional and physical experiences of hospitalized children*. 2(4), 399–401.
<https://doi.org/10.15761/CCRR.1000227>
- Romito, B., Jewell, J., & Jackson, M. (2021). Child life services. *Pediatrics*, 147(1), 1–10.
<https://doi.org/10.1542/PEDS.2020-040261>
- Saglik, D. S., & Caglar, S. (2019). The effect of parental presence on pain and anxiety levels during invasive procedures in the pediatric emergency department. *J Emerg Nurs*, 45(3), 278–285.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jen.2018.0>

- Shen, T., Wang, X., Xue, Q., & Chen, D. (2023). Active versus passive distraction for reducing procedural pain and anxiety in children: a meta-analysis and systematic review. *Italian Journal of Pediatrics*, 49(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13052-023-01518-4>
- Shi, Y., & Wu, W. (2023). Multimodal non-invasive non-pharmacological therapies for chronic pain: mechanisms and progress. *BMC Medicine*, 21(1), 1–29. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-03076-2>
- Sillero, A. S., Margañon, R. A., & Marques-sule, E. (2024). *Child-Centered Care: A Qualitative Study Exploring Pediatric Hospitalization Through Children ' s Perspectives*. 3138–3149.
- Sundal, H., & Vatne, S. (2020). Parents' and nurses' ideal collaboration in treatment-centered and home-like care of hospitalized preschool children – A qualitative study. *BMC Nursing*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00445-7>
- Trottier, E. D., Doré-Bergeron, M. J., Chauvin-Kimoff, L., Baerg, K., & Ali, S. (2019). Managing pain and distress in children undergoing brief diagnostic and therapeutic procedures. *Paediatrics and Child Health (Canada)*, 24(8), 509–521. <https://doi.org/10.1093/pch/pxz026>
- van Oort, P. J. S., Maaskant, J. M., Smeulders, M., van Oostrum, N., Vermeulen, E., & van Goudoever, J. B. (2019). Participation of Parents of Hospitalized Children in Medical Rounds: A Qualitative Study on Contributory Factors. *Journal of Pediatric Nursing*,

- Wang, Y., Lu, H., Li, S., Zhang, Y., Yan, F., Huang, Y., Chen, X., Yang, A., Han, L., & Ma, Y. (2022). Effect of Cold and Heat Therapies on Pain Relief in Patients With Delayed Onset Muscle Soreness: a Network Meta-Analysis. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 54. <https://doi.org/10.2340/jrm.v53.331>
- Wati, S. (2016). Evaluasi Kejadian Nyeri pada Anak yang Dirawat di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*.
- Wen-ying, Y., Li, Z., An-wei, X., Pei-rong, L., & Jin-xia, Y. (2018). Questionnaire development and reliability and validity analysis of inpatient children's parent participation in care. *Journal of Nursing Administration*, 18(1), 8–11.
- Wieland, L. S. (2019). Psychological Interventions for Needle-Related Procedural Pain and Distress in Children and Adolescents: Summary of a Cochrane Review. *Explore*, 15(1), 74–75. <https://doi.org/10.1016/j.explore.2018.10.014>
- Xiao, C., Akiko, S. H., Melissa, T., & Allison, A. A. (2020). The relationship between parental involvement in childhood and depression in early adulthood. *Journal of Affective Disorders*, 273, 173–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.03.108>
- Yang, J. xia, Zhang, W. yan, Huang, H. huan, Jiang, W. ting, Zhou, Y. feng, Gu, Y., Xu, H. zhen, Yao, W. ying, & Zhang, F. (2023). Parental involvement in postoperative pain management among children in a urology ward: A

best practice implementation project. *Nursing Open*, 10(5), 3042–3051.
<https://doi.org/10.1002/nop2.1551>

Zhu, L. (2023). *Process Evaluation of a Pain Management Educational Intervention for Parents of Children Undergoing Elective Surgery*.
<https://doi.org/10.20944/preprints202309.0800.v1>

GLOSARIUM

A

Adenokortikoid: adalah hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari yang memicu pengeluaran hormon stres

Alkalosis: adalah tingginya kadar basa dalam darah

Artritis: adalah peradangan pada sendi

Atektasis: adalah kondisi ketika alveolus tidak terisi udara sehingga paru tidak dapat mengembang

B

Biologis: adalah sifat yang berkaitan dengan makhluk hidup

D

Diagnostik: adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi gejala

Dorsal: adalah bagian belakang dari sebuah permukaan atau bagian tubuh

F

Farmakologis: adalah pemberian obat untuk mengatasi gejala/penyakit

Fisiologis: adalah fungsi normal tubuh

G

Ganglion: adalah bongkahan jaringan biologis

Glukagon: adalah hormon yang berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah

H

Hiperalgesia: adalah meningkatnya respon nyeri terhadap stimulus

Hospitalisasi: adalah kondisi dimana seseorang menjalani perawatan di rumah sakit

I

Injuri: adalah cedera yang mengakibatkan kerusakan pada bagian tubuh

Intrakranial: di dalam kepala/otak

Intraventrikular: adalah di dalam ventrikel

Invasif: adalah tindakan yang menyebabkan luka pada tubuh

J

Jaringan: adalah sekelompok sel tubuh yang memiliki fungsi sama

K

Katabolik: adalah proses pemecahan molekul dalam makanan menjadi bagian yang lebih kecil

Katekolamin: adalah hormon yang dilepaskan tubuh ketika mengalami stres

Kognitif: adalah aktivitas yang berkaitan dengan pikiran, persepsi, ingatan, dan pengolahan informasi

Kortikosteroid: adalah obat anti peradangan

Kuratif: adalah tindakan pengobatan

N

Edukasi Manajemen Nyeri Dengan Media Elektronik Untuk Meningkatkan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Ibu Dalam Manajemen Nyeri Anak Selama Hospitalisasi

Neurotransmitter: adalah sinyal kimia yang dilepaskan dari terminal saraf

Nonfarmakologis: adalah tindakan mengurangi gejala tanpa obat

Norepinefrin: adalah golongan obat yang bekerja menaikkan denyut jantung

Nosiseptor: adalah reseptor yang memberi sinyal rangsangan

O

Otitis media: adalah infeksi pada telinga tengah

P

Pneumonia: adalah infeksi pada parenkim paru

Prognosis: adalah perkiraan atau prediksi tentang perkembangan penyakit

Psikologis: adalah kondisi yang berkaitan dengan mental atau jiwa

R

Roleplay: adalah bermain peran

S

Sensori: adalah sesuatu yang berhubungan dengan panca indera

Serotonin: adalah zat kimia dalam tubuh yang berperan dalam pengendalian emosi

Somatik: adalah sel-sel dalam tubuh

Substantia gelatinosa: adalah kumpulan sel di area abu-abu sumsum tulang belakang

T

Termal: adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suhu
V

Visceral: adalah organ internal tubuh

PROFIL PENULIS



Ns. Dera Alfiyanti, M.Kep. Lahir di Semarang, 16 April 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang dan Pendidikan Profesi Ners di universitas yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan (Peminatan Keperawatan Anak) di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006

sebagai dosen pengajar di Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang sampai dengan sekarang. Mata kuliah utama yang diampu adalah Keperawatan Anak 1, Keperawatan Anak 2, Praktik Profesi Keperawatan Anak, dan Praktik Klinik Keperawatan Anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dera.alfiyanti@unimus.ac.id



Dr. Ns. Vivi Yosafianti Pohan, M.Kep. Lahir di Jakarta, 15 Februari 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 dan S3 Keperawatan di Universitas Indonesia. Penulis merupakan dosen tetap pada Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Mata

kuliah utama yang diampu adalah Manajemen Keperawatan dan Praktik Profesi Keperawatan Anak. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: vyp@unimus.ac.id

SINOPSIS BUKU

Monograf ini mengkaji peranan media elektronik sebagai alat edukasi dalam pengelolaan nyeri pada anak yang menjalani perawatan di rumah sakit. Fokus utama buku ini adalah bagaimana media elektronik dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua dalam menangani nyeri anak selama masa perawatan. Buku ini membahas berbagai pendekatan pengelolaan nyeri, baik yang berbasis obat maupun teknik non-obat, yang dapat diterapkan orang tua dengan bantuan informasi yang jelas dan mudah diakses. Dilengkapi dengan bukti penelitian dan contoh kasus, buku ini menggambarkan bagaimana media elektronik dapat meningkatkan peran aktif orang tua dalam perawatan anak, yang pada akhirnya membantu mempercepat pemulihan anak secara lebih nyaman dan efektif.

Selain itu, buku ini mengulas dampak positif dari peningkatan pengetahuan orang tua tentang pengelolaan nyeri. Dengan menyediakan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, media elektronik membantu orang tua dalam mengenali gejala nyeri, memahami berbagai pilihan pengobatan, serta memperbaiki sikap mereka dalam menghadapi nyeri anak. Buku ini juga menyoroti pentingnya kerja sama yang erat antara orang tua dan tenaga medis dalam menciptakan pendekatan perawatan yang lebih komprehensif dan efektif, serta bagaimana teknologi dapat mendukung orang tua dalam mengelola nyeri anak dengan lebih baik.

Melalui monograf ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana edukasi yang efektif dapat diberikan dalam format yang mudah diakses dan dimengerti, salah satunya penggunaan media elektronik. Buku ini menunjukkan bagaimana media elektronik dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat dalam membantu orang tua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola nyeri anak. Selain itu, monograf ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan teknologi ini dan memberikan rekomendasi untuk pengembangannya di masa depan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya media edukasi digital dalam meningkatkan kualitas perawatan anak di rumah sakit.

Monograf ini mengkaji peranan media elektronik sebagai alat edukasi dalam pengelolaan nyeri pada anak yang menjalani perawatan di rumah sakit. Fokus utama buku ini adalah bagaimana media elektronik dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua dalam menangani nyeri anak selama masa perawatan. Buku ini membahas berbagai pendekatan pengelolaan nyeri, baik yang berbasis obat maupun teknik non-obat, yang dapat diterapkan orang tua dengan bantuan informasi yang jelas dan mudah diakses. Dilengkapi dengan bukti penelitian dan contoh kasus, buku ini menggambarkan bagaimana media elektronik dapat meningkatkan peran aktif orang tua dalam perawatan anak, yang pada akhirnya membantu mempercepat pemulihan anak secara lebih nyaman dan efektif.

Selain itu, buku ini mengulas dampak positif dari peningkatan pengetahuan orang tua tentang pengelolaan nyeri. Dengan menyediakan informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami, media elektronik membantu orang tua dalam mengenali gejala nyeri, memahami berbagai pilihan pengobatan, serta memperbaiki sikap mereka dalam menghadapi nyeri anak. Buku ini juga menyoroti pentingnya kerja sama yang erat antara orang tua dan tenaga medis dalam menciptakan pendekatan perawatan yang lebih komprehensif dan efektif, serta bagaimana teknologi dapat mendukung orang tua dalam mengelola nyeri anak dengan lebih baik.

Melalui monograf ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana edukasi yang efektif dapat diberikan dalam format yang mudah diakses dan dimengerti, salah satunya penggunaan media elektronik. Buku ini menunjukkan bagaimana media elektronik dapat menjadi sarana yang sangat bermanfaat dalam membantu orang tua meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola nyeri anak. Selain itu, monograf ini juga mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan teknologi ini dan memberikan rekomendasi untuk pengembangannya di masa depan. Secara keseluruhan, buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya media edukasi digital dalam meningkatkan kualitas perawatan anak di rumah sakit.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-92-4



9

786347

139924